

Buku 1

J.M. METHA'S MIDWIFERY SERIES:

PENYUSUNAN SOAL OSCE PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA

Panca Desristanto

Editor Isi : J. M. Metha

Editor Bahasa: Maryam Sorohiti



BUKU 1

J.M. METHA'S MIDWIFERY SERIES:

Penyusunan Soal OSCE

Pendidikan Kebidanan Indonesia

Penulis:
Panca Desristanto

Editor Isi:
J. M. Metha

Editor Bahasa:
Maryam Sorohiti



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BUKU 1

J.M. METHA'S MIDWIFERY SERIES:

Penyusunan Soal OSCE Pendidikan Kebidanan Indonesia

Penulis : Panca Desristanto

Editor Isi : J. M. Metha

Editor Bahasa : Maryam Sorohiti

Desain Sampul : Ivan Zumarano

Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-623-8775-61-3

Cetakan Pertama: Oktober, 2024

Hak Cipta © 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2024

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Prakata

Ujian Klinis Objektif dan Terstruktur (OSCE) adalah salah satu metode penilaian keterampilan klinis yang telah digunakan secara luas di berbagai institusi pendidikan kesehatan, seperti kebidanan, kedokteran, keperawatan, dan profesi kesehatan lainnya. OSCE dirancang untuk menilai berbagai aspek keterampilan klinis, mulai dari komunikasi dengan pasien, keterampilan prosedural, sampai pada kemampuan untuk mengambil keputusan dalam situasi klinis yang kompleks.

OSCE biasanya terdiri dari beberapa stasiun yang merepresentasikan situasi klinis spesifik. Setiap stasiun biasanya diatur dengan skenario simulasi yang menggambarkan masalah kesehatan tertentu, yaitu ketika peserta ujian diharapkan untuk melakukan tindakan klinis yang sesuai, seperti melakukan pemeriksaan fisik, memberikan diagnosis, menjelaskan prosedur kepada pasien, atau memberikan intervensi yang tepat. Dalam proses ini, penguji akan menggunakan rubrik yang telah distandarisasi untuk menilai keterampilan peserta secara objektif.

Keunggulan OSCE terletak pada kemampuannya untuk mengevaluasi aspek-aspek psikomotorik dan non-kognitif. Di samping keterampilan teknis, OSCE juga menilai aspek komunikasi interpersonal, empati, dan etika profesional yang sangat penting dalam praktik klinis. Ini menjadi sangat penting karena profesi kesehatan tidak hanya bergantung pada pengetahuan teoritis, tetapi juga pada kemampuan untuk menerapkannya dalam konteks nyata dengan mempertimbangkan aspek emosional dan sosial dari pasien.

Namun, penyelenggaraan OSCE memerlukan perencanaan yang teliti dan sumber daya yang besar. Logistik yang diperlukan meliputi ruang ujian, aktor simulasi (jika digunakan), penguji yang

terlatih, dan peralatan. Biaya yang terkait dengan persiapan ini cukup tinggi, terutama ketika mempertimbangkan kebutuhan untuk melibatkan banyak penguji dan memastikan standar penilaian yang konsisten di seluruh stasiun.

Meski demikian, manfaat yang ditawarkan oleh OSCE sering kali dianggap sebanding dengan tantangan logistiknya. Sebagai alat evaluasi yang komprehensif, OSCE memungkinkan identifikasi kelemahan dalam kurikulum pendidikan, baik dari segi materi ajar maupun keterampilan klinis yang diajarkan. Selain itu, OSCE juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta ujian dan pengajar, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan dapat disesuaikan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.

Pada akhirnya, jika dirancang dan diimplementasikan dengan baik, OSCE tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan secara keseluruhan, membangun kepercayaan diri peserta didik dalam keterampilan klinis mereka, serta mengasah kemampuan kritis dan analitis yang diperlukan dalam praktik medis. Untuk semua itu, penyusunan soal menjadi yang paling utama, seperti yang dijabarkan di dalam buku ini.

Penulis

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v
BAB 1 Dosen Sebagai Komponen Pendidikan Terpenting	1
BAB 2 Mengapa Harus OSCE?	6
BAB 3 Menyusun Soal OSCE	11
BAB 4 Kategori Klinis Kebidanan, Keterampilan Klinis Kebidanan, dan Cetak Biru	15
BAB 5 Perilaku Profesional	20
BAB 6 Kasus, Skenario Kasus Klinis, dan Instruksi Penguji	24
BAB 7 Rubrik Penilaian	30
BAB 8 Manusia atau Manekin	34
BAB 9 Alat dan Bahan Habis Pakai dan Pengaturan Alat	40
BAB 10 Contoh Soal OSCE	41
BAB 11 Template dan Contoh Isi Template	45
BAB 12 Penutup: Pentingnya Penguasaan Keterampilan Klinis Oleh Bidan	64
Daftar Pustaka	69
Biodata Penulis dan Editor	71

BAB 1

Dosen Sebagai Komponen Pendidikan Terpenting

Dosen merupakan komponen terpenting dalam pendidikan, di samping siswa dan kurikulum. Harden dan Laidlaw (2027)¹ mengatakan bahwa dosen berperan sangat penting untuk keberhasilan atau kegagalan program pendidikan. Terlebih lagi, mereka mengatakan bahwa tidak ada kuliah yang buruk; yang ada hanyalah dosen yang buruk atau tidak berkualitas. Mengajar, seperti keterampilan klinis, merupakan titik kritis dalam transfer ilmu: jika dosen tidak melakukannya dengan benar, hal ini dapat memiliki implikasi serius lainnya.

Misalkan, jika kita mengetik 'sejajar lantai' pada prosedur manajemen aktif kala III di mesin pencari Google atau lainnya,² dalam hitungan seperberapa detik kita akan sudah mendapat ribuan hasilnya. Padahal, ilmu sejajar lantai tidak ditemukan pada referensi barat manapun kecuali sejajar panggul. Ilmu yang tidak tepat ini akan selalu ditularkan ke siswa-siswa calon bidan oleh dosen-dosen yang kurang membaca referensi keilmuan manajemen aktif kala III yang bukan ditulis oleh bidan di Indonesia.

¹ Harden, R.M and Laidlaw, J.M. (2017) Essential Skills for A Medical Teacher: An Introduction to Teaching and Learning in Medicine. Second edition. Elsevier.

² <https://www.google.com/search?q=sejajar+lantai+manajemen+aktif+kala+3>

Pertanyaannya adalah bagaimana jika soal ujian kinis ditulis oleh dosen yang belum mengerti bahwa frasa 'sejajar lantai' bukan merupakan ilmu yang benar? Siswa yang diajar oleh dosen dengan materi yang benar dan membaca referensi yang benar akan menjadi salah karena pembuat soal bukan dosen yang kompeten secara klinis. Tentu saja, hal ini sangat merugikan pendidikan kebidanan.

Para dosen, untuk memenuhi peran pendidikan mereka, perlu memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Dosen harus dapat membuat perbedaan pada kualitas pengalaman belajar siswa. Itulah sebabnya bahwa dosen lebih dari sekadar penyampai informasi dan keterampilan tetapi mereka memfasilitasi pembelajaran siswa dan melakukannya dengan berbagai cara. Akibatnya, mengajar merupakan seni sekaligus ilmu. Beberapa dosen secara naluri merupakan dosen yang baik, tetapi yang lainnya tidak. Namun, fakta yang meyakinkan adalah bahwa seni dan ilmu mengajar dapat dipelajari. Dosen yang berpengalaman dapat mengembangkan lebih jauh naluri mengajar mereka dan guru baru dapat dibantu untuk memperoleh naluri ini serta kompetensi, sikap, dan profesionalisme yang diperlukan.

Hanushek (2011)³ mengatakan bahwa hal terpenting yang dapat dilakukan institusi pendidikan adalah menyediakan dosen yang berkualitas bagi siswa-siswanya. Berkualitas di sini mengandung arti bahwa dosen diharapkan mampu untuk menransfer keterampilannya kepada para siswa, yaitu kemampuan yang benar untuk ditunjukkan secara benar. Dalam pendidikan kebidanan, dosen yang diharapkan adalah bahwa dosen yang mengajar teori dapat langsung mempraktikkan teori yang diterangkan tersebut dihadapan para siswa, tentu saja dengan syarat teori benar dan demonstrasi keterampilan yang benar. Pentingnya kemampuan

³ Hanushek, E. A. (2011). The economic value of higher teacher quality. *Economics of Education Review*, 30(3), 466–479.

dosen yang disebutkan ini diperkuat oleh perkataan Andreas Schleicher⁴ bahwa

"We need to attract the best and brightest to join the profession. Teachers are the key in today's knowledge economy, where a good education is an essential foundation for every child's future success."

"Kita perlu menarik orang-orang terbaik dan tercerdas untuk bergabung dengan profesi ini. Pengajar adalah kunci dalam ekonomi berbasis pengetahuan saat ini, di mana pendidikan yang baik adalah fondasi penting bagi kesuksesan masa depan setiap anak."

Oleh karena itu, kualitas dosen dipandang sebagai penggerak utama dalam meningkatkan prestasi siswa dan dengan demikian mendorong daya saing ekonomi dalam masyarakat global.⁵

Pengajaran yang baik jelas penting untuk meningkatkan prestasi siswa; namun, masih belum jelas apa yang menjadikan seorang dosen yang berkualitas. Penelitian ekstensif tentang kualitas dosen menunjukkan bahwa dosen yang berkualitas memiliki beberapa atribut, yaitu: pendidikan formal dan pengalaman dosen.⁶ Namun, pada kenyataannya, dosen-dosen sekolah vokasi di negara ini direkrut tanpa menunjukkan pengalaman praktik di lapangan yang cukup. Dosen-dosen yang baru cenderung direkrut dari lulusan terbaik yang hanya menunjukkan keahlian 'menghawal' materi pembelajaran dan materi ujian oleh kakak tingkat mereka. Padahal,

⁴ OECD Director for Education and Skills, speaking on the occasion of the launch of the Teaching and Learning International Survey (TALIS)

⁵ National Academies. (2007). Study of teacher preparation programs in the United States. Retrieved December 1, 2006, from <http://www.nationalacademies.org/teacherprep/>

⁶ Meroni, E. C., Vera-Toscano, E., & Costa, P. (2015). *Can low skill teachers make good students? Empirical evidence from PIAAC and PISA. Journal of Policy Modeling, 37*(2), 308–323. doi:10.1016/j.jpolmod.2015.02.006

inilah yang menyebabkan 'dosen teori' menjadi tidak kompeten ketika menunjukkan:

- Analisis kasus di lapangan dan
- Demonstrasi asuhan klinis.

Mengintegrasikan teori dengan praktik merupakan aspek penting dalam pengembangan keterampilan klinis di kalangan siswa kebidanan. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan secara efektif ke dalam praktik berperan penting dalam mencapai hasil yang optimal serta menjaga keselamatan pasien. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa integrasi teori ke dalam praktik dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya pengalaman klinis dosen.⁷ Dosen yang berkualitas dalam teori dan praktik akan menghasilkan soal-soal asesmen yang berkualitas juga karena soal-soal yang dibuat tentu saja sudah berdasarkan pada pengalaman di lapangan bertahun-tahun.

Pengalaman praktis dalam lingkungan asuhan kesehatan merupakan dasar pendidikan kebidanan. Tujuan utama dari pengalaman praktis adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional siswa, dan juga melibatkan peningkatan keterampilan penelitian, berpikir kritis, harga diri, pengambilan keputusan independen, dan komunikasi interpersonal yang efektif. Kualitas pembelajaran praktis terkait erat dengan kualitas lingkungan pembelajaran klinis. Motivasi akademik siswa bahkan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan pembelajaran klinis mereka.⁸ Keberhasilan pendidikan di lingkungan klinis dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor

⁷ González-Fernández, R., Ruiz-Cabezas, A., Domínguez, M. C. M., Subía-Álava, A. B., & Salazar, J. L. D. (2024). Teachers' teaching and professional competences assessment. *Evaluation and program planning*, 103, 102396. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2023.102396>

⁸ Aktaş, Y. Y., & Karabulut, N. (2016). A Survey on Turkish nursing students' perception of clinical learning environment and its association with academic motivation and clinical decision making. *Nurse Education Today*, 36, 124-128.

tersebut adalah dosen, siswa, profesional kesehatan yang bekerja di klinik, dan lingkungan fisik. Jika satu atau beberapa faktor ini tidak memadai, misalnya dosen, pendidikan klinis mungkin tidak tercapai pada tingkat yang diinginkan.

An objective structured clinical examination (OSCE) merupakan ujian klinis bagi siswa pendidikan kesehatan. Dengan demikian, soal-soal yang disusun harus sesuai dengan standar praktik di lapangan **yang benar**. Saya menulis buku ini dengan alasan bahwa buku pertama dari serangkaian buku pendidikan kebidanan J.M. Metha akan memberikan paradigma baru bagi para dosen pendidikan kebidanan dalam memilih ilmu yang benar yang akan diteruskan kepada para siswa. Pada akhirnya, lulusan bidan yang cerdas dihasilkan oleh dosen bidan yang cerdas pula.

BAB 2

Mengapa Harus OSCE?

Dalam praktik kebidanan, memastikan keselamatan perempuan dan bayi baru lahir merupakan prioritas utama. Keterampilan klinis yang mumpuni sangat penting untuk menghadapi berbagai situasi sebelum, selama, dan setelah persalinan. Oleh karena itu, pendidikan kebidanan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga menekankan pada penguasaan keterampilan klinis yang tepat dan aman. Salah satu metode yang efektif untuk menilai keterampilan klinis adalah Ujian Klinis yang Objektif dan Terstruktur (OSCE).⁹

Penilaian yang ketat melalui OSCE tidak hanya penting dalam mengukur keterampilan teknis siswa kebidanan, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi untuk menangani situasi klinis nyata dengan aman dan efektif. OSCE merupakan metode penilaian yang terdiri dari serangkaian stasiun, yaitu ketika peserta diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas klinis dalam waktu yang telah ditentukan. Tugas ini mencakup berbagai skenario yang mungkin ditemui bidan dalam praktik klinis, seperti memantau tanda vital ibu, atau menangani komplikasi persalinan.

OSCE dipandang sebagai metode yang efektif karena kemampuannya untuk menilai keterampilan klinis secara holistik. Tidak hanya keterampilan teknis seperti palpasi atau resusitasi neonatal yang diuji, tetapi juga kemampuan komunikasi,

⁹ Mitchell, M. L., Jeffrey, C. A., Henderson, A., Glover, P., Nulty, D. D., Kelly, M. A., ... Knight, S. (2014). *Using an Objective Structured Clinical Examination for Bachelor of Midwifery students' preparation for practice. Women and Birth, 27(2), 108–113.* doi:10.1016/j.wombi.2013.12.002

pengambilan keputusan klinis, dan penerapan pengetahuan teoritis ke dalam praktik nyata. Dalam hal ini, OSCE menjamin bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan keselamatan dan kompetensi klinis telah diperiksa secara menyeluruh.

Pelaksanaan OSCE bertujuan untuk memastikan bahwa parameter yang diperlukan untuk penilaian yang ketat terpenuhi. Ini termasuk keselamatan, akurasi, dan relevansi klinis. Tanpa memenuhi standar-standar ini, penilaian keterampilan klinis tidak akan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang kompetensi siswa, yang pada akhirnya dapat membahayakan keselamatan pasien di kemudian hari.

Ketika dilaksanakan sebelum penempatan klinis, OSCE memberikan banyak manfaat bagi siswa kebidanan, terutama mereka yang belum memiliki pengalaman langsung di lapangan. Melalui simulasi, siswa dapat mempraktikkan keterampilan yang dibutuhkan dalam situasi nyata, tetapi dalam lingkungan yang lebih terkontrol dan aman. Hal ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih berulang kali, sehingga mereka dapat memperbaiki kekurangan dan memperkuat kemampuan mereka sebelum terjun ke praktik klinis yang sesungguhnya.

Simulasi dalam OSCE juga memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mental internal, yaitu kemampuan untuk merencanakan, berpikir, dan mengantisipasi tindakan mereka saat menghadapi situasi klinis. Kemampuan ini penting karena dapat membantu siswa beradaptasi lebih baik saat menghadapi tantangan di lapangan, seperti komplikasi persalinan atau kondisi ibu yang memburuk secara mendadak.

Penelitian telah menunjukkan bahwa siswa kebidanan lebih menyukai OSCE dibandingkan dengan penilaian praktis di

lingkungan klinis nyata.¹⁰ OSCE memberikan kesempatan bagi siswa untuk dinilai secara objektif dan adil, tanpa harus menghadapi tekanan langsung dari situasi klinis yang nyata, yaitu ketika kesalahan dapat memiliki konsekuensi serius. Dengan demikian, OSCE tidak hanya menjadi alat penilaian yang efektif, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih tenang dan terstruktur.

Meskipun OSCE menawarkan banyak manfaat, pelaksanaannya juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah tingkat kecemasan yang tinggi yang dialami oleh siswa selama OSCE. Meskipun OSCE adalah lingkungan simulasi, siswa sering kali merasa tertekan karena harus menyelesaikan tugas klinis dalam waktu yang terbatas dan di bawah pengawasan penguji. Tekanan ini dapat memengaruhi kinerja siswa dan mengurangi efektivitas penilaian.

Aspek praktis pelaksanaan OSCE juga membutuhkan perhatian khusus. Organisasi dan persiapan yang kurang matang dapat berdampak negatif pada keseluruhan pengalaman siswa. Kejelasan instruksi, komunikasi yang efektif antar-tim pengajar, dan perencanaan logistik yang baik sangat penting untuk memastikan OSCE berjalan lancar. Jika salah satu dari elemen ini tidak terpenuhi, siswa mungkin akan merasa bingung dan tidak mampu menunjukkan keterampilan terbaik mereka selama ujian.

Panduan OSCE seperti buku yang ditulis ini juga menyoroti pentingnya relevansi klinis dari skenario yang digunakan dalam OSCE. Skenario yang dipilih harus mencerminkan situasi nyata yang mungkin dihadapi oleh bidan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, tingkat kesulitan skenario harus sesuai dengan tingkat pendidikan siswa. Siswa tingkat awal, misalnya, mungkin tidak siap untuk

¹⁰ Sweet L, Glover P. (2011). Utilizing follow throughs in midwifery. In: Billett S, Henderson A, editors. Developing learning professional integrating experiences in university and practice settings. USA: Springer.

menangani skenario kegawatdaruratan yang kompleks, sementara siswa tingkat akhir harus diberi tantangan yang lebih tinggi untuk menguji kesiapan mereka dalam praktik mandiri.

Dalam konteks program Sarjana Kebidanan (Bachelor of Midwifery/BM), penggunaan OSCE menjadi semakin penting karena lulusan diharapkan dapat berpraktik sebagai bidan yang mandiri dan kompeten. OSCE memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi klinis yang umum dan signifikan, seperti persalinan normal, perawatan ibu pasca-persalinan, dan penanganan komplikasi kehamilan.

Dengan mengikuti OSCE, siswa kebidanan dapat belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan teoretis dengan keterampilan praktis, serta meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan klinis mereka. Keterampilan ini sangat penting karena dalam praktik klinis, bidan sering kali harus membuat keputusan cepat yang dapat berdampak langsung pada keselamatan ibu dan bayi.

Selain itu, OSCE juga membantu dosen dan penguji dalam mengidentifikasi area mana siswa mungkin membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Umpan balik yang diberikan setelah OSCE dapat membantu siswa memahami kelemahan mereka dan bekerja untuk memperbaikinya sebelum terjun ke lapangan. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan kebidanan secara keseluruhan dan memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan klinis.

Dalam pendidikan kebidanan kontemporer, penilaian keterampilan klinis melalui OSCE merupakan alat yang sangat berharga untuk memastikan kompetensi dan keselamatan siswa dalam menghadapi situasi klinis nyata. OSCE memberikan siswa kesempatan untuk berlatih dan menguji keterampilan mereka dalam lingkungan yang aman dan terstruktur, sekaligus

memungkinkan pengajar untuk mengevaluasi kemampuan siswa secara objektif dan menyeluruh.

Namun, pelaksanaan OSCE memerlukan perencanaan yang matang dan komunikasi yang efektif antara tim pengajar untuk memastikan bahwa pengalaman siswa positif dan produktif. Dengan demikian, OSCE dapat menjadi alat yang kuat dalam membekali siswa kebidanan dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi bidan yang kompeten dan profesional.

BAB 3

Menyusun Soal OSCE

Ujian Klinis yang Objektif dan Terstruktur (OSCE) merupakan metode penilaian yang sangat efektif untuk menilai kompetensi klinis di bidang kebidanan. OSCE dirancang untuk menilai berbagai keterampilan klinis yang diperlukan oleh calon bidan, termasuk kemampuan teknis, pengambilan keputusan, keterampilan komunikasi, dan etika profesional. Penyusunan soal OSCE dalam pendidikan kebidanan membutuhkan perencanaan yang matang, dengan tujuan untuk menciptakan ujian yang valid, reliabel, dan mencerminkan kondisi klinis yang sesungguhnya.

Langkah pertama dalam penyusunan soal OSCE adalah menentukan keterampilan spesifik yang ingin dinilai. Dalam konteks kebidanan, kompetensi ini bisa mencakup keterampilan dalam menangani persalinan normal, asuhan antenatal, asuhan ibu dan bayi pasca-persalinan, serta identifikasi dan penanganan kondisi komplikasi. Keterampilan lain seperti komunikasi dengan ibu hamil, etika dalam praktik kebidanan, dan keterampilan edukasi kepada pasien juga penting untuk dinilai.

Setiap stasiun OSCE harus dirancang berdasarkan skenario klinis yang realistis dan relevan dengan praktik kebidanan. Skenario ini perlu mencerminkan situasi klinis yang sering ditemui bidan di lapangan, seperti memantau tanda vital ibu, memberikan asuhan selama persalinan, atau melakukan edukasi laktasi. Skenario yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas, misalnya apakah skenario tersebut ditujukan untuk menilai keterampilan teknis, pengetahuan klinis, atau komunikasi interpersonal.

Instruksi untuk peserta ujian harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik agar peserta tahu apa yang diharapkan dari mereka di setiap stasiun. Instruksi juga harus mencakup detail waktu yang dialokasikan untuk setiap stasiun, biasanya antara 5-10 menit.

Rubrik penilaian dalam OSCE sangat penting untuk memastikan penilaian yang objektif dan konsisten. Rubrik tersebut harus mencakup berbagai aspek keterampilan yang ingin dinilai, mulai dari pengetahuan, keterampilan teknis, hingga komunikasi dengan pasien. Setiap tindakan harus memiliki kriteria penilaian yang jelas dan terukur, misalnya apakah tindakan dilakukan dengan urutan yang benar, apakah peserta mengidentifikasi masalah dengan tepat, dan apakah penjelasan kepada pasien diberikan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Dalam beberapa stasiun OSCE, penggunaan aktor simulasi sangat membantu untuk menilai kemampuan peserta dalam berinteraksi dengan pasien. Aktor simulasi dapat memainkan peran ibu hamil, ibu menyusui, atau ibu dengan komplikasi kehamilan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai 'pasien' yang dapat memberikan gejala atau masalah kesehatan tertentu, tetapi juga sebagai pengamat yang memberikan umpan balik tentang kualitas komunikasi peserta.

Penyusunan soal OSCE tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam konteks kebidanan. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

1. Validasi Soal dan Skenario

Soal OSCE harus valid, artinya benar-benar mengukur kompetensi yang ingin dinilai. Proses validasi ini bisa dilakukan melalui konsultasi dengan para ahli kebidanan atau penguji senior untuk memastikan soal yang disusun relevan dan sesuai dengan standar praktik klinis.

2. Logistik dan Pengorganisasian

OSCE membutuhkan sumber daya yang signifikan, baik dari segi waktu, ruang, maupun tenaga penguji. Setiap stasiun perlu disiapkan dengan peralatan yang sesuai, dan penguji harus dilatih untuk menggunakan rubrik penilaian secara konsisten. Selain itu, jadwal ujian harus diatur agar setiap peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk dinilai tanpa gangguan.

3. Variasi Keterampilan Peserta

Peserta OSCE sering kali memiliki tingkat keterampilan dan pengalaman yang berbeda-beda. Soal OSCE harus dirancang untuk menilai semua tingkatan kemampuan peserta, mulai dari yang baru belajar hingga yang sudah lebih mahir. Ini berarti soal harus cukup menantang untuk mengukur kompetensi yang lebih tinggi, tetapi juga memungkinkan peserta pemula untuk menunjukkan kemajuan mereka.

Penyusunan soal OSCE untuk pendidikan kebidanan merupakan proses yang kompleks, tetapi sangat penting untuk menilai dan memastikan kompetensi klinis calon bidan. Dengan perencanaan yang matang, pengembangan skenario yang realistis, dan rubrik penilaian yang objektif, OSCE dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mengevaluasi kemampuan teknis, pengambilan keputusan, serta keterampilan komunikasi yang dibutuhkan dalam praktik kebidanan. Tantangan dalam penyelenggaraan OSCE, seperti validasi soal dan logistik, harus diatasi dengan perencanaan yang baik agar ujian dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang akurat serta bermanfaat bagi pengembangan peserta didik.

Jika dikaitkan dengan alat-alat kebidanan yang digunakan, tantangan kemudian muncul. Tantangan yang sering dihadapi oleh institusi pendidikan adalah keterbatasan anggaran untuk menyediakan alat bantu ajar yang mahal dan canggih. Namun, dengan pendekatan yang inovatif dan kreatif, banyak alternatif alat

bantu ajar *low cost* yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan klinis tanpa mengurangi kualitas pendidikan.

Berbagai keterampilan klinis kebidanan memerlukan alat bantu ajar yang mendukung simulasi nyata, tetapi tidak harus selalu menggunakan peralatan mahal. Pendidikan kebidanan yang berkualitas tidak selalu harus bergantung pada alat bantu ajar yang mahal. Dengan kreativitas dan inovasi, banyak alat bantu ajar *low cost* yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan klinis penting, seperti pemeriksaan antenatal, persalinan, asuhan pasca-persalinan, dan penanganan kegawatdaruratan. Penggunaan alat bantu sederhana seperti boneka bayi, manekin buatan, fetoskop, model panggul daur ulang, dan video edukasi dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik dengan cara yang efektif dan terjangkau.

Dengan demikian, institusi pendidikan kebidanan dapat terus menyediakan pelatihan yang berkualitas meskipun memiliki keterbatasan anggaran, dan calon bidan tetap dapat mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi profesional yang kompeten. J.M. Metha sebagai bidan senior serta pendidik dan pelatih di bidan kebidanan telah mengembangkan alat-alat bantu ajar yang diperlukan untuk pembelajaran keterampilan klinis kebidanan. Jika kualitas keterampilan klinis para calon bidan perlu untuk disolidkan, alat-alat bantu ajar keterampilan klinis dari J.M. Metha merupakan solusi luar biasa yang dapat untuk dipertimbangkan.

Bab-bab berikutnya akan fokus membahas hal-hal apa saja yang diperlukan dalam menyusun soal OSCE. Pemahaman penyusunan soal ini sangat bergantung pada penguasaan materi dosen. OSCE merupakan ujian demonstrasi atau prosedur sehingga dosen diharapkan sudah sangat matang dalam menguasai materi klinis untuk memproduksi soal-soal yang berkualitas.

BAB 4

Kategori Klinis Kebidanan, Keterampilan Klinis Kebidanan, dan Cetak Biru

KATEGORI KLINIS KEBIDANAN

Kategori klinis adalah nama kategori layanan kesehatan, misalnya penyakit dalam, THT, dst.¹¹ Untuk kebidanan, kategori klinisnya adalah asuhan kebidanan, seperti kehamilan, persalinan, dst. Sebelum kita bahas kategori dalam OSCE kebidanan, sebaiknya, kita paham terlebih dahulu tentang lingkup praktik kebidanan, yaitu: lingkup normal dan patologi. Patologi terbagi menjadi deteksi dini, kegawatdaruratan obstetrik, dan neonatal. Ketika terdeteksi masalah patologi, bidan harus tahu apakah termasuk deteksi dini atau kegawatdaruratan. Bila deteksi dini, bidan wajib melakukan kolaborasi/konsultasi (tergantung fasilitas kesehatannya) dan siap dengan rujukan. Berbeda dengan kegawatdaruratan, bidan harus mampu melakukan penanganan awal terlebih dahulu sebelum dilakukan kolaborasi/rujukan. Oleh sebab itu, urutan pemilihan kategori OSCE kebidanan adalah sebagai berikut:

1. Masa antara/prakonsepsi: normal/deteksi dini
2. Kehamilan: Normal
3. Kehamilan: Deteksi Dini/Gadar
4. Persalinan: Normal
5. Persalinan: Deteksi Dini/Gadar
6. Nifas/Buteki: Normal/Deteksi Dini

¹¹ <https://www.hcf.com.au/Campaigns/phi-reforms-faqs/standard-clinical-definitions>

7. Bayi baru lahir sd. 28 hari: Normal/Deteksi Dini/Gadar
8. Keluarga Berencana: Normal/Deteksi dini

Delapan kategori ini berarti bahwa terdapat delapan stasiun atau ruang tempat peserta ujian mendemonstrasikan keterampilan klinis kebidanan.

KETERAMPILAN KLINIS KEBIDANAN

Memahami hubungan antara kompetensi klinis (*clinical competency*) dan keterampilan klinis (*clinical skill*) sama halnya dengan menghargai cara kerja jam tangan yang rumit. Setiap roda gigi dan pegas, meskipun fungsinya berbeda, bekerja sama dengan mulus untuk memastikan keakuratan dan keandalan. Kompetensi dan keterampilan saling terkait dengan cara yang sama untuk menghasilkan sistem asuhan kesehatan yang berupaya mencapai keunggulan.

Kompetensi klinis dapat dianggap sebagai cetak biru menyeluruh yang memandu para profesional asuhan kesehatan. Kompetensi ini mencakup **kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap** yang diperlukan untuk menjalankan peran seseorang secara efektif. Kompetensi ini adalah standar yang digunakan untuk menilai pekerja asuhan kesehatan, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dibutuhkan baik secara etis maupun profesional.

Keterampilan klinis, di sisi lain, adalah roda gigi individual dalam cetak biru ini. Keterampilan ini adalah **tugas-tugas spesifik** dan akademis yang dilakukan oleh seorang pekerja asuhan kesehatan, seperti mengukur tekanan darah atau memberikan suntikan. Keterampilan ini adalah ekspresi nyata dari kompetensi seorang profesional. Keterampilan klinis adalah kemampuan yang

digunakan profesional asuhan kesehatan saat menilai, mendiagnosis, dan mengasuh pasien.¹²

Untuk OSCE kebidanan, keterampilan klinis yang diujikan ini berawal dari kinerja seorang bidan bila menghadapi pasien/kasus. Pertama, perlu data untuk mengetahui apa kondisi pasien (normal atau patologi). Untuk mendapatkan data ini, bidan harus mampu melakukan 1) anamnesis dan 2) pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana. Ingat 4 jenis pemeriksaan fisik (inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi). Selain pemeriksaan fisik, bidan juga dapat melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana untuk menunjang kesimpulan dari kondisi pasien seperti pemeriksaan tes kehamilan, Hb, protein urine, dan urine reduksi.

Setelah mendapatkan data, bidan akan menyimpulkan kondisi pasien yang tertuang dalam 3) perumusan diagnosis dan/atau masalah yang perlu diintervensi. Untuk intervensi, bidan akan melakukan 4) prosedur tindakan, 5) KIE/Konseling, dan 6) Kolaborasi/Rujukan. Sebagai bukti bahwa semua keterampilan ini dilakukan maka bidan wajib melakukan pencatatan yang bisa kita kenal dengan sebutan 7) pendokumentasian. Ringkasnya, daftar keterampilan klinis kebidanan yang diujikan adalah:

1. Anamnesis
2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana
3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah
4. Prosedur tindakan klinis
5. KIE/konseling
6. Kolaborasi/Rujukan
7. Pendokumentasian

Keterampilan ini akan menjadi jumlah tugas dalam soal. OSCE merupakan salah satu ujian kompetensi. Untuk itu, pengetahuan dan keterampilan perlu dilengkapi dengan kemampuan

¹² <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-are-clinical-skills>

komunikasi dan sikap-sikap tenaga kesehatan bidan, yang dijabarkan pada perilaku profesional.

Selanjutnya, kategori dan keterampilan disatukan dalam satu cetak biru (*blueprint*) yang akan menjadi kisi-kisi soal dalam satu periode ujian. Artinya, soal-soal yang muncul dalam satu periode akan berbeda dengan soal-soal di periode selanjutnya. Cetak biru pada pendidikan kebidanan vokasi D3 dan profesi agak berbeda. Berikut diberikan contoh cetak biru untuk profesi.

CETAK BIRU OSCE PENDIDIKAN PROFESI KEBIDANAN

Kategori		Minimum (%)	Kespro (masa antara, pra-konsepsi)		Kehamilan (Trimester I, II, dan III)		Persalinan (Kala I-II-III dan Kala pengawasan sd 2 jam postpartum)		Nifas (mulai dari > 2 jam post-partum sd hari ke-42) dan Masa laktasi	Neo-natus sejak lahir sd 28 hari	KB
			N/DD		N	DD/ Gadar	N	DD/ Gadar	N/DD	N/DD/ Gadar	N/ DD
Kompetensi			Kasus								
No.		Stasiun	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Anamnesis	30/2-3									
2.	Pemeriksaan fisik/penunjang	60/4-5									
3.	Perumusan diagnosis/ masalah	40/3-4									
4.	Tindakan klinis	60/4-5									
5.	KIE/ Konseling	30/2-3									
6.	Kolaborasi/ Rujukan	20/1-2									
7.	Pendokumentasian	40/3-4									

Catatan:

- N=normal; DD=deteksi dini; Gadar=kegawatdaruratan
- Setiap kompetensi harus diimbangi dengan perilaku profesional (dibahas pada BAB 5)

BAB 5

Perilaku Profesional

Perilaku profesional bidan di tempat kerja merupakan gabungan dari sikap, penampilan, dan tata krama.¹³ Ini mencakup cara berbicara, berpenampilan, bertindak, dan membuat keputusan.

Prinsip utama perilaku kerja profesional meliputi:

- Memperlakukan pasien dengan hormat
- Menunjukkan sikap positif
- Bersikap sopan
- Menunjukkan penilaian yang baik
- Bersikap etis
- Berpakaian yang pantas

Perilaku profesional melekat pada diri dan semua tindakan tenaga kesehatan, termasuk bidan, ketika mereka sedang melakukan tugasnya.¹⁴ Praktik kebidanan menuntut perilaku proaktif, yang dapat meningkatkan efisiensi kerja, kepuasan kerja, komitmen dan sikap mengatasi terhadap ketahanan terhadap stres. Untuk itu, bidan perlu memahami secara holistik dan membiasakan perilaku profesional bidan di tempat kerja.¹⁵

¹³ <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/professional-behavior-workplace>

¹⁴ Patey, A. M., Fontaine, G., Francis, J. J., McCleary, N., Presseau, J., & Grimshaw, J. M. (2023). Healthcare professional behaviour: health impact, prevalence of evidence-based behaviours, correlates and interventions. *Psychology & health*, 38(6), 766–794. <https://doi.org/10.1080/08870446.2022.2100887>

¹⁵ Mestdagh, E., Timmermans, O., Fontein-Kuipers, Y., & Van Rompaey, B. (2019). Proactive behaviour in midwifery practice: A qualitative overview based on midwives' perspectives. *Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives*, 20, 87–92. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2019.04.002>

Saat ini, sebagian orang percaya bahwa tenaga kesehatan kurang altruistik (berorientasi pada kepentingan pasien) dibandingkan di masa lalu, dan hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap profesi kesehatan ini. Ada pula ancaman dan faktor yang membuat kita lebih memerhatikan kategori perilaku profesional dibandingkan sebelumnya. Faktor dan ancaman tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, internal dan eksternal. Beberapa faktor internal dan ancaman perilaku profesional adalah: penyalahgunaan kekuasaan, kesombongan, keserakahan, pemberian informasi palsu (kebohongan dan penipuan), kurangnya ketelitian, dan konflik kepentingan. Pengetahuan dan keahlian yang tidak memadai juga dapat mengancam perilaku profesional kesehatan.¹⁶

Dalam sebuah studi tinjauan¹⁷ ditunjukkan bahwa ada hubungan antara perilaku tidak profesional dan hasil yang merugikan seperti membahayakan pasien, ketidakpuasan pasien, dan tuntutan hukum malapraktik medis. Terlebih lagi, ada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa siswa yang memiliki perilaku tidak profesional selama masa studi mereka melanjutkan tren ini dalam kinerja mereka di masa mendatang sebagai tenaga kesehatan.¹⁸ Singkatnya, perilaku profesional dalam program pendidikan

¹⁶ Schlesinger M. (2002). A loss of faith: The sources of reduced political legitimacy for the American medical profession. *The Milbank Quarterly*. 80(2):185-235

¹⁷ Bahaziq, W., & Crosby, E. (2011). Physician professional behaviour affects outcomes: a framework for teaching professionalism during anesthesia residency. *Canadian journal of anaesthesia = Journal canadien d'anesthésie*, 58(11), 1039–1050. <https://doi.org/10.1007/s12630-011-9579-2>

¹⁸ Papadakis, M. A., Hodgson, C. S., Teherani, A., & Kohatsu, N. D. (2004). Unprofessional behavior in medical school is associated with subsequent disciplinary action by a state medical board. *Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges*, 79(3), 244–249. <https://doi.org/10.1097/00001888-200403000-00011>

kesehatan adalah penting dan harus diajarkan, termasuk pada OSCE.

Perilaku profesional yang perlu ditunjukkan peserta ujian dalam OSCE adalah sebagai berikut:

- A. Komunikasi (anamnesis, kolaborasi, KIE/Konseling)
 - 1. Berkomunikasi dengan jelas (menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dengan intonasi yang jelas);
 - 2. Memperlihatkan non-verbal yang sesuai, termasuk gestur yang tepat, mempertahankan kontak mata, dst;
 - 3. Menunjukkan perhatian untuk mendengarkan secara aktif;
 - 4. Bersikap santun kepada lawan bicara secara tepat dan sesuai;
 - 5. Melaksanakan komunikasi dua arah.
- B. Prosedur kerja (pemeriksaan, tindakan)
 - 1. Mengutamakan keselamatan pasien, diri, dan lingkungan, termasuk meminimalkan cedera dan mempertahankan prinsip PI;
 - 2. Melakukan pekerjaan secara tepat dengan teliti dan rapi;
 - 3. Tetap mempertahankan komunikasi walaupun berhadapan dengan panthom;
 - 4. Menjaga privasi;
 - 5. Memperlakukan alat-alat dengan menunjukkan sikap kehati-hatian.
- C. Dokumentasi
 - 1. Tulisan rapi dan jelas;
 - 2. Jika ada koreksi, coretan hanya satu garis, diberi paraf, dan diperbaiki.

Perilaku profesional hampir ada di semua kerangka kemampuan pendidikan kesehatan, termasuk kebidanan, dan semua sekolah kebidanan seharusnya memasukkannya ke dalam kurikulum mereka, walaupun mereka masih memiliki tantangan dalam

mengajarkannya. Metode pendidikan akan efektif ketika lingkungan pendidikan (universitas dan rumah sakit) mendorong perilaku profesional dan mencegah perilaku tidak profesional seseorang. Tampaknya, sistem pendampingan sangat diperlukan dalam struktur pendidikan kesehatan untuk memandu pembentukan identitas profesional.

Dengan mengadakan pertemuan rutin dan berkelanjutan dengan sekelompok pembelajar tertentu, para mentor memberikan umpan balik dan membimbing mereka untuk memikirkan kembali pengalaman klinis mereka, dan di satu sisi, mereka membantu pembelajar beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian, stres, dan masalah yang terjadi pada mereka dan merehabilitasi, dan membantu memperbaiki perilaku mereka. Selain itu, pendampingan membantu mengidentifikasi tantangan sistem pendidikan yang menciptakan kurikulum tersembunyi. Dalam struktur di mana siswa memiliki rotasi jangka pendek di departemen khusus dan superspesialis, seseorang tidak dapat mengharapkan pelatihan perilaku profesional yang efektif kecuali dengan sistem pendampingan. Lingkungan yang mendukung dan kebijakan insentif, membantu peserta didik dalam ketahanan, dan meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka juga merupakan langkah-langkah lain yang dapat efektif dalam meningkatkan perilaku profesional peserta didik.

Itu semua akan bagus ketika pengajarnya adalah dosen yang sudah bertahun-tahun berpraktik lapangan dan bukan dosen tanpa pengalaman sehingga pembelajaran bukan didasarkan pada khayalan dosen. Dengan disusunnya perilaku profesional dalam buku ini, saya harapkan bahwa hal ini akan memudahkan penyusun soal dalam membuat rubrik penilaian yang berkenaan dengan perilaku.

BAB 6

Kasus, Skenario Kasus Klinis, dan Instruksi Penguji

KASUS KLINIS

Kebanyakan bidan setuju bahwa setiap hari berbeda dalam menangani pasien dan mereka tidak pernah tahu apa yang akan dihadapi. Hal ini tercakup dalam kasus-kasus yang akan dimunculkan dalam soal OSCE. Kasus klinis merupakan 'topik' yang akan dihadapi oleh peserta ujian dan akan dimunculkan dalam skenario kasus. Oleh karena itu, gambaran praktik klinik di lapangan harus dikuasai oleh penyusun soal.

Misalnya, kategori tentang 'kehamilan normal' akan dibuatkan kasus menjadi 'Kehamilan normal anak kedua dari ibu yang berumur 31 tahun.' Detail kondisi ibu akan dijabarkan di skenario kasus. Penyusun diharapkan untuk memberikan data yang benar dalam skenario kasus yang akan dibuat. Jika kategorinya 'normal', penyusun harus menyajikan data yang 'normal' juga.

SKENARIO KASUS KLINIS

Skenario (*vignette* atau vinyet) atau 'sandiwara singkat' telah digunakan dalam pendidikan ilmu kesehatan:

*Vignette-based methodologies are frequently used to examine judgments and decision-making processes, including clinical judgments made by health professionals.*¹⁹

Metodologi berbasis vinyet sering digunakan untuk menguji penilaian dan proses pengambilan keputusan, termasuk penilaian klinis yang dibuat oleh profesional kesehatan.

Skenario yang disusun harus berisikan data-data yang benar. Di sinilah letak kesulitan para dosen yang tidak mempunyai gambaran klinis asuhan kebidanan di lapangan karena data-data yang dimunculkan akan cenderung bertabrakan. Berikut diberikan gambaran data-data dalam skenario yang kurang atau tidak relevan.

CONTOH 1

Seorang perempuan, umur 22 tahun, G2P0A0, usia kehamilan 24 minggu, datang ke PMB dengan keluhan nyeri punggung.

Catatan: jika soal digiring ke arah kehamilan fisiologis, apakah usia 24 minggu sudah menyebabkan keluhan nyeri punggung (lihat teori besaran uterus berdasarkan jumlah minggu)?

CONTOH 2

Seorang perempuan, umur 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 28 minggu, datang ke PMB dengan keluhan keluar darah per vaginam. Hasil anamnesis: darah keluar tanpa disertai mulas. Hasil

¹⁹ Evans, S. C., Roberts, M. C., Keeley, J. W., Blossom, J. B., Amaro, C. M., Garcia, A. M., ... Reed, G. M. (2015). *Vignette methodologies for studying clinicians' decision-making: Validity, utility, and application in ICD-11 field studies. International Journal of Clinical and Health Psychology, 15*(2), 160–170. doi:10.1016/j.ijchp.2014.12.001

pemeriksaan: tanda vital dalam rentang normal, kontraksi belum ada, pembukaan serviks 3 cm.

Catatan: tidak ada indikasi untuk colok vagina karena belum inpartu (tidak ada his) dan kontra-indikasi karena melakukan colok vagina ketika terjadi pendarahan per vaginam.

CONTOH 3

Seorang perempuan, umur 27 tahun, P1A0, datang ke PMB untuk menunda kehamilan. Hasil anamnesis: ingin ber-KB jangka panjang, umur anak 6 bulan, haid sudah lima hari ini. Hasil pemeriksaan: TD 120/70 mmHg, N 80 x/menit, P 20x/menit, S 36,40C, plano tes (-), dst.

Catatan: apakah perlu menuliskan hasil pemeriksaan plano dengan hasil negatif ketika pasien sudah mengungkapkan haid yang telah berjalan 3 hari?

CONTOH 4

Seorang perempuan, umur 25 tahun, P1A0, nifas 6 jam, datang ke PMB dengan keluhan nyeri pada luka jahitan perineum. Hasil anamnesis: takut nyeri pada luka saat BAK. Dst

Catatan: mungkin nifas 6 jam datang ke layanan kesehatan dengan kondisi nyeri pada area genetalia? Faktanya adalah bahwa pasien masih sulit jalan, kecuali gawat darurat yang diantar.

Soal pilihan ganda berbasis skenario klinis dalam ujian tertulis (Piramida Miller tingkat 2) tentu saja berbeda dengan soal OSCE (Piramida Miller tingkat 3). Konsekuensinya adalah bahwa kemampuan dalam membuat kedua jenis soal ini merupakan keterampilan wajib yang harus dikuasai oleh pengajar di lingkungan pendidikan kesehatan, tanpa terkecuali pendidikan kebidanan. Pembuatan atau penyusunan soal yang melibatkan unsur terpenting, yaitu praktik lapangan oleh pengajar, menjadi dasar akan 'logika' yang benar dari soal yang tersusun. Dengan

disahkannya pendidikan profesi bidan di Indonesia, kualitas soal harus dipandang dari beberapa unsur penting, seperti *clinical reasoning* dan bahasa. Akan tetapi, dua jenis ujian tersebut (tertulis dan OSCE) mensyaratkan penyusun soal untuk dapat membuat *vignette* (skenario) dengan data yang logis dan relevan serta penyajian yang benar.

Untuk memperjelas perbedaan dari soal pilihan ganda dan OSCE, berikut diberikan dua contoh soal pilihan ganda tertulis dan soal OSCE yang keduanya sama-sama memasukkan *vignette* atau skenario. Keduanya tentu saja mempunyai perbedaan yang signifikan, khususnya dalam bentuk perintah soal dan kelengkapan penilaian.

JENIS	CONTOH SOAL
<u>Pilihan ganda tertulis</u>	Seorang perempuan, umur 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, sedang berada di ruang bersalin PMB. Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 80 x/menit, P 20 x/menit, S 37⁰ C, TFU 32 cm, DJJ 136 x/menit, kontraksi uterus 5/10'/50", terlihat kepala bayi membuka vulva 5-6 cm. Secara prosedur, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? - Mengajar meneran - Mamakai sarung tangan - Melakukan <i>vulva hygiene</i> - Meminta ibu miring ke kiri - Memasang <i>under-pad</i> dan handuk
<u>OSCE</u>	Seorang perempuan, umur 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, sedang berada di ruang bersalin PMB. Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 80 x/menit, P 20 x/menit, S 37⁰ C, TFU 32 cm, DJJ 136 x/menit, kontraksi uterus 5/10'/50", terlihat kepala bayi membuka vulva 5-6 cm. Bidan meletakkan <i>under-pad</i> di bawah bokong ibu dan handuk di atas abdomen.

	Tugas: 1. Tulis diagnosis pada kertas yang telah tersedia! 2. Pasang APD! 3. Lakukan pertolongan persalinan mulai dari memasang <i>under-pad</i> sampai bayi dibungkus dengan handuk di atas abdomen ibu! Catatan: 1. Buat rubrik penilaian tentang diagnosis yang benar, langkah-langkah persalinan kala 2 dari pasang <i>under-pad</i> sampai bayi dibungkus dengan handuk dan masih terletak di atas abdomen ibu, dan perilaku profesional. 2. Pasang APD tidak perlu dinilai karena ini sudah dilakukan sebelum memasang <i>under-pad</i>.
--	---

Pesan, sekali lagi, yang paling penting untuk disampaikan di sini adalah bahwa penyusun soal mampu memberikan kasus dan skenario kasus klinis dengan data yang benar. Untuk memudahkan penyusunan skenario, sebenarnya penyusun cukup memberikan skenario dan tugas sebagai berikut:

Skenario

Anda sedang memberikan layanan kepada seorang ibu hamil (26 tahun) yang mengatakan bahwa dia sudah telat haid selama 12 minggu. Padahal, haid sebelumnya teratur dan baru kali ini sempat ke bidan.

Tugas

1. Lakukan anamnesis terfokus.
2. Lakukan pemeriksaan abdomen.

Soal ini akan terasa aman untuk penyusun soal, tetapi, tentu saja, soal selamanya tidak akan berupa seperti ini. Tetap saja, penyusun harus memastikan untuk mampu menulis soal-soal dengan informasi akurat di dalam skenarionya.

INSTRUKSI PENGUJI

Pada dasarnya, untuk OSCE di Indonesia, penguji dilarang untuk berinteraksi dengan peserta. Akan tetapi, aturan ini tidak bersifat mutlak sehingga instruksi khusus diperkenalkan untuk mengabaikan pelarangan tersebut. Instruksi penguji terdiri atas:

- Instruksi umum yang berisikan aturan-aturan umum bagi penguji terhadap ujian dan peserta;
- Instruksi khusus yang berisikan hal-hal yang dapat dilakukan penguji untuk berinteraksi dengan peserta; dan
- Instruksi tambahan yang berkenaan dengan pengaturan kembali alat dan bahan sebelum peserta baru memasuki stasiun.

BAB 7

Rubrik Penilaian

Rubrik adalah alat penilaian yang mengidentifikasi berbagai kriteria yang relevan dengan tugas, penilaian, atau hasil pembelajaran dan menyatakan kemungkinan tingkat pencapaian dengan cara yang spesifik, jelas, dan objektif. Rubrik digunakan untuk menilai pekerjaan siswa berbasis proyek termasuk esai, proyek kelompok, usaha kreatif, dan presentasi lisan. Rubrik dapat membantu instruktur mengomunikasikan harapan kepada siswa dan menilai pekerjaan siswa secara adil, konsisten, dan efisien. Rubrik dapat memberikan umpan balik informatif kepada siswa tentang kekuatan dan kelemahan mereka sehingga mereka dapat merefleksikan kinerja mereka dan mengerjakan area yang perlu ditingkatkan.

Untuk OSCE di Indonesia, rubrik penilaian diberikan dua bentuk yaitu a) nilai aktual dan b) nilai performa keseluruhan, yaitu pendapat penguji tentang kemampuan keseluruhan peserta uji dalam melaksanakan tugas klinis. Untuk nilai aktual, rubrik penilaiannya didasarkan dari penyederhanaan dari rubrik penilaian panduan belajar. Jadi, rubrik akan lebih singkat karena penguji diasumsikan sudah menguasai keterampilan klinis yang diujikan secara terperinci.

Penilaian atau skor aktual mempunyai rentang 0 sampai 3, yaitu (dari 3 ke 0) secara garis:

- 3 untuk tugas yang dilakukan sempurna.
- 2 untuk tugas yang dilakukan sempurna setengah plus 1 atau pembulatan ke atas dari total langkah penilaian.
- 1 untuk tugas yang dilakukan sempurna dari 1 sampai batas penilaian skor 2.
- 0 untuk tugas yang tidak dilakukan.

Penilaian performa keseluruhan berentang dari luar biasa sampai gagal.

Syarat menjadi penguji OSCE harus ketat. Mereka harus mengetahui benar setiap rincian langkah baik prosedur pemeriksaan maupun prosedur tindakan klinis. Oleh karena itu, penyusun soal hanya menuliskan garis besar langkah dan bukan seluruh langkah seperti yang tertulis pada penuntun belajar. Semua individu yang ingin menjadi penguji OSCE harus menunjukkan bahwa mereka merupakan, idealnya, dosen yang memenuhi kriteria seperti terdaftar sebagai bidan yang berpraktik; memiliki setidaknya tiga tahun pengalaman pada praktik lapangan; dan selalu up-to-date sesuai dengan pedoman nasional yang relevan, persyaratan organisasi kebidanan, dan pelatihan keterampilan klinis kebidanan. Pembuat soal harus mampu membedakan antara daftar tilik penuntun belajar dan daftar tilik penilaian. Dalam rubrik penilaian, pembuat soal menulis daftar tilik penilaian dan bukan daftar tilik penuntun belajar. Daftar tilik penilaian ditulis dengan singkat-tepat-jelas tanpa mengdurangi prinsip langkah-langkah prosedur yang harus dikerjakan. Hal ini bertujuan agar yang lulus benar-benar peserta ujian yang kompeten.

Penuntun Belajar	Penilaian
Persiapan: 1. Mempersiapkan alat - Memeriksa fungsi dan posisi batere - Melakukan percobaan apakah tensimeter layak digunakan 2. Mempersiapkan diri - Cuci tangan - Pasang sarung tangan (pada situasi tertentu, seperti masa covid) 3. Mempersiapkan lingkungan	1. Mempersiapkan atau mengecek alat yang telah tersedia 2. Mempersiapkan diri 3. Mempersiapkan lingkungan 4. Mempersiapkan pasien Setelah memposisikan lengan: 5. Mengoperasionalkan alat 6. Membaca hasil

- Menutup pintu ruangan/kamar - Memberi pembatas (bila lebih dari satu pasien di ruang an tersebut) Prinsipnya: menjaga privasi 4. Mempersiapkan pasien - Menginformasikan tindakan yang akan dilakukan - Memposisikan pasien (duduk atau berbaring) - Memposisikan lengan yang akan dipasang manset (sejajar letak jantung)	7. Menunjukkan kepada pasien hasil ukur sebelum menekan tombol off. 8. Menyelesaikan tindakan
Langkah-langkah pengukuran Setelah memposisikan lengan: 5. Mendekatkan tensimeter ke arah lengan pasien yang akan diperiksa 6. Memasang manset di atas fosa kubiti ($\pm 2 - 3$ cm dari lipatan siku 7. Mengoperasionalkan alat: - tekan tombol on - membiarkan alat bekerja - memperhatikan angka pada alat sampai alat menunjukkan angka hasil pengukuran (TD dan Nadi) 8. Menunjukkan kepada pasien/keluarga pasien hasil TD dan nadi	
9. Menyelesaikan tindakan: - Menekan tombol off - Melepaskan manset	

- Meletakkan alat pada tempat semula - Memastikan posisi pasien nyaman - Mencatat hasil di lembar rekam medis pasien	
--	--

BAB 8

Manusia atau Manekin

MANUSIA

Pasien Simulasi

Dalam pendidikan kesehatan, misalnya OSCE, pasien simulasi (PS) adalah individu yang dilatih untuk bertindak sebagai pasien sungguhan guna mensimulasikan serangkaian gejala atau masalah. Pasien simulasi telah berhasil digunakan untuk pendidikan, evaluasi profesional kesehatan, serta penelitian medis dasar, terapan, dan translasional. PS juga dapat berkontribusi pada pengembangan dan peningkatan protokol asuhan kesehatan; terutama dalam kasus di mana masukan dari PS didasarkan pada pengalaman dan pengamatan langsung yang luas sebagai pasien klinis yang menjalani perawatan. Mereka digunakan secara luas dalam pendidikan klinis untuk memungkinkan siswa berlatih dan meningkatkan keterampilan klinis dan percakapan mereka untuk pertemuan pasien yang sebenarnya.

Untuk OSCE, PS digunakan secara luas dalam pengujian keterampilan klinis siswa, biasanya sebagai bagian dari pemeriksaan klinis terstruktur yang objektif. PS juga berguna untuk melatih siswa mempelajari perilaku profesional dalam situasi yang berpotensi memalukan seperti pemeriksaan panggul, payudara, atau pemeriksaan dalam. Dengan PS, pemeriksaan dapat dilakukan secara hybrid, yaitu PS memberikan percakapan dan manekin sebagai alat untuk diperiksa.

Panduan Dialog

Ketika PS dihadapkan pada, misalnya, anamnesis atau konseling, PS harus memberikan respons sesuai dengan kasus yang

diperankannya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh peserta ujian dapat dijawab dengan panduan dialog. PS tidak menghafal per kata tetapi jawaban sesuai konteks. Ini merupakan sarana ujian komunikasi untuk peserta sehingga 'komunikasi' tidak perlu diberikan stasiun khusus.

MANEKIN

Manekin digunakan untuk tugas yang minim dengan komunikasi atau berhubungan dengan area intim. Manekin yang digunakan seharusnya bersifat murah (*low cost*) dan realistis serta awet. **OSCE pada dasarnya adalah ujian simulasi.** Jadi, semaksimal mungkin, alat dan bahan, termasuk manekin, yang digunakan bersifat murah sehingga siswa dapat berlatih berulang kali sebelum mereka melakukan OSCE yang sebenarnya. Ibu J.M. Metha sudah membuat beberapa alat bantu belajar yang dapat digunakan untuk pembelajaran klinis atau OSCE; beberapa di antaranya sudah mendapatkan hak paten.

Berikut alat-alat bantu ajar yang sudah dibuat oleh Ibu J.M. Metha:

1. Alat cangkokan yang dapat digunakan untuk pembelajaran/penilaian keterampilan klinis manajemen aktif kala 3 atau MAK 3, manual plasenta, dan katerisasi.

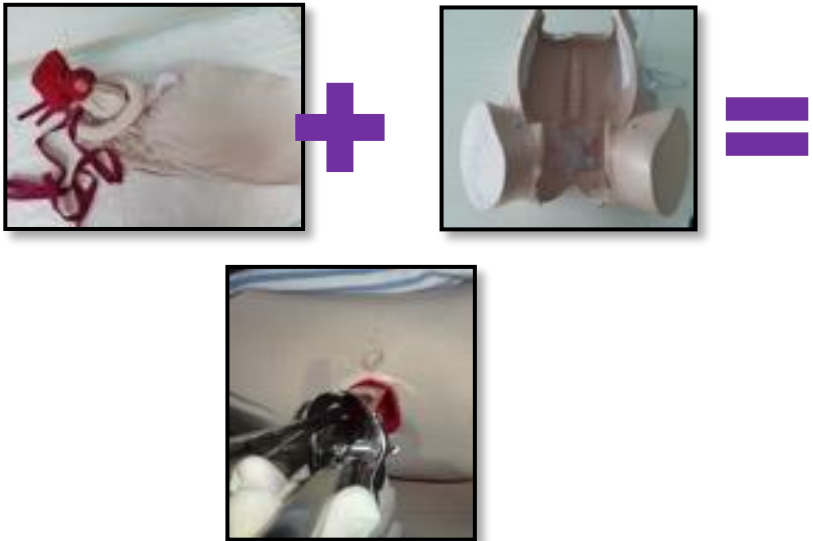




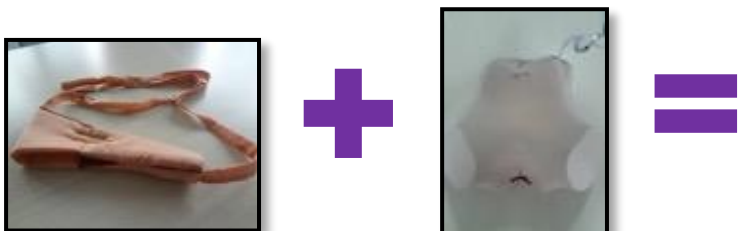
2. Alat cangkokkan yang dapat digunakan untuk pembelajaran/penilaian keterampilan klinis persalinan presentasi kepala, bokong, kaki, dan katerisasi.



3. Alat cangkokkan yang dapat digunakan untuk pembelajaran/penilaian keterampilan klinis pemasangan dan pencabutan AKDR serta katerisasi.



4. Alat cangkokkan yang dapat digunakan untuk pembelajaran/penilaian keterampilan klinis penjahitan perineum derajat 2.





5. Alat cangkokkan yang dapat digunakan untuk pembelajaran/penilaian keterampilan pemasangan dan pencabutan AKBK



Alat dapat dipasang pada lengan pasien simulasi



5.1. Pemasangan AKBK



5.2. Pencabutan AKBK

Alat-alat di atas semestinya dimiliki oleh setiap siswa atau sekelompok siswa untuk berlatih keterampilan klinis kebidanan. Institusi kebidanan dapat memfasilitasi para siswanya untuk mendapatkan model atau alat bantu ajar pembelajaran klinis kebidanan ini, melalui whatsapp ke nomor 08127345657.

BAB 9

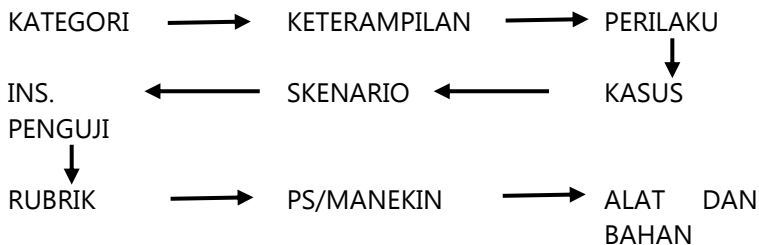
Alat dan Bahan Habis Pakai dan Pengaturan Alat

Semua alat dan bahan yang diperlukan harus disiapkan. Untuk aturan jumlahnya, alat berat dan alat/bahan habis pakai berbeda. Untuk alat/bahan habis pakai, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah peserta dalam satu putaran ditambah beberapa cadangan. Semua alat harus diletakkan sesuai dengan posisinya masing-masing.

BAB 10

Contoh Soal OSCE

Penyusunan soal OSCE harus dilakukan dengan seksama karena hal ini berkaitan dengan kevalidan data yang disusun oleh penyusun soal. Alur penyusunan soal dapat dilihat berikut ini:



Langkah-langkah di atas dikenal sebagai 9 Langkah Soal OSCE, yaitu:

1. Tentukan kategori;
2. Tentukan keterampilan;
3. Tentukan perilaku berdasarkan keterampilan;
4. Tentukan kasus;
5. Kembangkan skenario;
6. Tentukan instruksi penguji;
7. Tentukan rubrik penilaian (di lembar di luar template);
8. Tentukan karakteristik PS atau manekin; dan
9. Tentukan alat dan bahan.

Dari langkah-langkah tersebut, saya contohkan satu per satu:

1. Tentukan kategori
 - Kategorinya: Kehamilan Gadar
2. Tentukan keterampilan
 - Pemeriksaan fisik
 - Prosedur tindakan klinis
 - Pendokumentasian
 - Perilaku profesional
3. Tentukan perilaku profesional berdasarkan keterampilan
 - Prosedur
 - Dokumentasi
4. Tentukan kasus
 - Kasus: Penanganan pasien hamil dengan eklamsi
5. Skenario
 - Anda sedang menghadapi seorang pasien dengan diagnosis medis eklamsi dengan TD 210/120 mmHg, hamil 32 minggu di ruang IGD RS. Tong spatel, infus MgSO₄ telah terpasang. Saat ini, pasien akan dilakukan pemasangan dower catheter.
 - Tugas
 - 1) Lakukan pemasangan kateter.
 - 2) Setelah kateter terpasang, lakukan pemantauan TD dan dengarkan penguji menyebutkan hasil setelah pengukuran ini selesai dilakukan.
 - 3) Catat implementasi dan evaluasi hasil tindakan yang dilakukan pada kertas yang tersedia dan serahkan kepada menguji catatan tersebut.

NB: Urutan tugas dapat dibolak-balok, misalnya, Tugas 1 merupakan Keterampilan 2 dan Tugas 2 merupakan Keterampilan 1, dst. Kebanyakan, keterampilan dan tugas dilakukan secara berurutan. Hanya untuk kasus-kasus tertentu, keterampilan dan tugas dapat dibolak-balik urutannya.

6. Tentukan instruksi penguji
 - Lihat pada Tugas 2. Penguji mengatakan hasil pemeriksaan TD; hal ini berarti bahwa penguji akan mengatakan hasil ini kepada penguji (Lihat lebih terperinci pada contoh template).
7. Tentukan rubrik penilaian

Nilai aktual

1. Pemasangan kateter	2. Pengukuran TD	3. Pendokumen-tasi	4. Perilaku
1. Mempersiapka n diri 2. Mengecek peralatan 3. Memposisikan pasien 4. Memastikan orifisium uretra siap untuk dimasukkan kateter 5. Memasukkan kateter ke dalam orifisium uretra 6. Memastikan urine keluar 7. Melakukan fiksasi kateter bagian dalam 8. Menyambungk an kateter dengan urine bag 9. Melakukan fiksasi selang kateter bagian luar 10. Memposisikan urine bag 11. Menyelesaikan tindakan	Tensimeter Digital 1. Mempersiapkan diri 2. Memastikan alat siap pakai 3. Mempersiapkan lengan yang akan diukur (memastikan aliran infus tidak mengalir) 4. Mendekatkan alat 5. Memasang manset 6. Mengoperasional kan alat 7. Menyelesaikan pengukuran	Rubrik terlampir	Pemeriksaan dan tindakan klinis: 1. Mengutamakan keselamatan pasien, diri, dan lingkungan, termasuk meminimalkan cedera dan mempertahankan prinsip PI 2. Melakukan pekerjaan secara tepat dengan teliti dan rapi 3. Tetap mempertahankan komunikasi walaupun berhadapan dengan panthom 4. Menjaga privasi Pendokumentasian 5. Tulisan rapi dan jelas 6. Jika ada koreksi, coretan hanya satu garis, diberi paraf, dan diperbaiki

8. Pilih PS, manekin, atau hybrid
- Manekin: Model panggul perempuan hamil yang pada area genitalia dapat digunakan untuk pemasangan kateter.
 - Bagian bawah model panggul dialasi dengan underpad dan bagian atas model panggul ini diberikain penutup (selimut).
 - Di bagian samping bawah model panggul tersebut diletakkan:
 - a) Bak instrumen yang berisikan seperangkat alat untuk pemasangan dower kateter telah disiapkan. Seperangkat alat tersebut terdiri dari:
 - sepasang sarung tangan
 - kom kecil yang bertuliskan "betadine"
 - spuit minimal 20 mL (sebaiknya yang 50 mL) dalam keadaan telah dilepas dari kemasannya
 - kasa
 - b) Kom yang bertuliskan air DTT
 - c) Kom yang diisi dengan kapas dan pada bagian luar kom ditulis dengan "kapas DTT"
 - d) Tube yang seolah-olah berisi "jelly"
 - e) Kateter Foley dalam kemasan
 - f) Urine bag yang sudah dikeluarkan dari kemasan
 - Di samping model panggul ini diletakkan model lengan yang telah dipasang infus (kondisikan asal netes)
9. Tentukan alat dan bahan serta pengaturan alatnya di ruangan.

BAB 11

Template dan Contoh Isi Template

TEMPLATE SOAL DAN RUBRIK PENILAIAN

NO	ITEM	PENJELASAN
1.	INSTRUKSI UMUM PENGUJI	- Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. - Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: - Ujian lokal 2-digit jika peserta berjumlah 01-99 3-digit jika peserta berjumlah 100-999 4-digit terakhir jika menggunakan NIM peserta - Ujian nasional 4-digit jika peserta berjumlah ribuan atau 4-digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka. - Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan rubrik penilaian: <i>Actual mark</i> (0/1/2/3) <i>Global rating</i> (1/2/3/4) - Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apapun (interupsi, bertanya, menghentikan, dst) kepada peserta selain yang ditentukan. - Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji UK OSCE
2.	NO. STASIUN	Tulis nomor ini sesuai dengan nomor stasiun pada blueprint

NO	ITEM	PENJELASAN
3.	JUDUL	Tebalkan 1 kategori yang dipilih: 1. Masa antara/prakonsepsi: normal/deteksi dini 2. Kehamilan: Normal 3. Kehamilan: Deteksi Dini/Gadar 4. Persalinan: Normal 5. Persalinan: Deteksi Dini/Gadar 6. Nifas/Buteki: Normal/Deteksi Dini 7. Bayi baru lahir sd. 28 hari: Normal/Deteksi Dini/Gadar 8. Keluarga Berencana: Normal/Deteksi dini
4.	TUJUAN	Tebalkan 3 keterampilan selain perilaku professional kompetensi yang akan diujikan: 1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/Rujukan 7. Pendokumentasian
5.	PERILAKU PROFESIONAL	Tebalkan beberapa item di bawah sesuai dengan kompetensi yang diujikan: A. Komunikasi (anamnesis, kolaborasi, KIE/Konseling) 1. Berkomunikasi dengan jelas (menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dengan intonasi yang jelas); 2. Memperlihatkan non-verbal yang sesuai, termasuk gestur yang tepat, mempertahankan kontak mata, dst; 3. Menunjukkan perhatian untuk mendengarkan secara aktif; 4. Bersikap santun kepada lawan bicara secara tepat dan sesuai;

NO	ITEM	PENJELASAN	
		5. Melaksanakan komunikasi dua arah. B. Prosedur kerja (pemeriksaan, tindakan) 1. Mengutamakan keselamatan pasien, diri, dan lingkungan, termasuk meminimalkan cedera dan mempertahankan prinsip PI; 2. Melakukan pekerjaan secara tepat dengan teliti dan rapi; 3. Tetap mempertahankan komunikasi walaupun berhadapan dengan panthom; 4. Menjaga privasi; 5. Memperlakukan alat-alat dengan menunjukkan sikap kehati-hatian. C. Dokumentasi 1. Tulisan rapi dan jelas; 2. Jika ada koreksi, coretan hanya satu garis, diberi paraf, dan diperbaiki.	
6.	KASUS, SKENARIO, TUGAS PESERTA UJIAN, INSTRUKSI KHUSUS PENGUJI, DAN LABORAN Catatan: Tentukan apakah menggunakan PS, manekin, atau hybrid (Coret yang tidak perlu).	KASUS Kasus berhubungan dengan kategori dan keterampilan.	
		SKENARIO (PS/Manekin/Hybrid) Buat kasus yang dapat menggambarkan situasi klinis yang sedang dihadapi bidan berdasarkan kategori yang telah ditentukan.	
		TUGAS PESERTA UJIAN Buat tugas yang berkaitan dengan kompetensi yang telah ditentukan untuk kasus ini di luar dari perilaku profesional.	INSTRUKSI KHUSUS PENGUJI 1. Instruksi ini merupakan pembatalan instruksi umum item 4. 2. Jika penguji tidak jelas dalam melihat tugas yang dilakukan peserta, penguji dapat mendekat kepada

NO	ITEM	PENJELASAN																											
		Jumlah tugas harus sama dengan jumlah kompetensi yang dipilih.	peserta tetapi tetap berada pada area belakang siswa. 3. Dst.																										
		INSTRUKSI TAMBAHAN PENGUJI <table><tr><th colspan="2">LABORAN</th></tr><tr><td>Ada</td><td>Bantu laboran.</td></tr><tr><td>Tidak ada</td><td>Rapikan alat dan siapkan BHP untuk peserta selanjutnya.</td></tr></table>		LABORAN		Ada	Bantu laboran.	Tidak ada	Rapikan alat dan siapkan BHP untuk peserta selanjutnya.																				
LABORAN																													
Ada	Bantu laboran.																												
Tidak ada	Rapikan alat dan siapkan BHP untuk peserta selanjutnya.																												
7.	DESKRIPSI PS ATAU/DAN MANEKIN, PANDUAN DIALOG PS, DAN SETTING ALAT	DESKRIPSI PS DESKRIPSI MANEKIN	PANDUAN DIALOG PS DAN PU <table><tr><th>PESERTA UJIAN</th><th>PASIENT SIMULASI</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	PESERTA UJIAN	PASIENT SIMULASI																								
PESERTA UJIAN	PASIENT SIMULASI																												
8.	KEBUTUHAN ALAT DAN BHP	ALAT DAN BHP <table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">ALAT DAN BHP</th><th colspan="2">JUMLAH</th></tr><tr><th>UTAMA</th><th>CADANGAN</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> *Untuk BHP, jumlah sesuai dengan jumlah peserta dalam satu periode putaran		NO	ALAT DAN BHP	JUMLAH		UTAMA	CADANGAN																				
NO	ALAT DAN BHP	JUMLAH																											
		UTAMA	CADANGAN																										

NO	ITEM	PENJELASAN
		PENGATURAN ALAT
9.	PENULIS	
10.	REFERENSI	

** Waktu ujian: **10 menit** (8 menit di dalam ruangan mengerjakan tugas, 2 menit di luar ruangan untuk perpindahan stasiun, istirahat, dan membaca soal)*

RUBRIK PENILAIAN UNTUK *ACTUAL MARK*

NO	ITEM		SKOR (3, 2, 1, 0)	
1.	KOMPETENSI		SKOR	KETERANGAN
	LANGKAH/ JAWABAN			
2.	KOMPETENSI		SKOR	KETERANGAN
	LANGKAH/ JAWABAN			
3.	KOMPETENSI		SKOR	KETERANGAN
	LANGKAH/ JAWABAN			
4.	KOMPETENSI		SKOR	KETERANGAN
	LANGKAH/ JAWABAN			

RUBRIK PENILAIAN UNTUK *GLOBAL PERFORMANCE*

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

CONTOH ISI TEMPLATE

NO	ITEM	PENJELASAN
1.	INSTRUKSI UMUM PENGUJI	- Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. - Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: - Ujian lokal 2-digit jika peserta berjumlah 01-99 3-digit jika peserta berjumlah 100-999 4-digit terakhir jika menggunakan NIM peserta - Ujian nasional 4-digit jika peserta berjumlah ribuan atau 4-digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka. - Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan rubrik penilaian: <i>Actual mark</i> (0/1/2/3) <i>Global rating</i> (1/2/3/4) - Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apapun (interupsi, bertanya, menghentikan, dst) kepada peserta selain yang ditentukan. - Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji UK OSCE
2.	NO. STASIUN	1
3.	JUDUL	Tebalkan 1 kategori yang dipilih: Masa antara/prakonsepsi: normal/deteksi dini

NO	ITEM	PENJELASAN
		2. Kehamilan: Normal 3. Kehamilan: Deteksi Dini/ Gadar 4. Persalinan: Normal 5. Persalinan: Deteksi Dini/Gadar 6. Nifas/Buteki: Normal/Deteksi Dini 7. Bayi baru lahir sd. 28 hari: Normal/Deteksi Dini/Gadar 8. Keluarga Berencana: Normal/Deteksi dini
4.	TUJUAN	Tebalkan 3 keterampilan selain perilaku professional kompetensi yang akan diujikan: 1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/Rujukan 7. Pendokumentasian
5.	PERILAKU PROFESIONAL	Tebalkan beberapa item di bawah sesuai dengan kompeensi yang diujikan: A. Komunikasi (anamnesis, kolaborasi, KIE/Konseling) 1. Berkomunikasi dengan jelas (menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dengan intonasi yang jelas); 2. Memperlihatkan non-verbal yang sesuai, termasuk gestur yang tepat, mempertahankan kontak mata, dst; 3. Menunjukkan perhatian untuk mendengarkan secara aktif;

NO	ITEM	PENJELASAN
		- Bersikap santun kepada lawan bicara secara tepat dan sesuai; - Melaksanakan komunikasi dua arah. B. Prosedur kerja (pemeriksaan, tindakan) - Mengutamakan keselamatan pasien, diri, dan lingkungan, termasuk meminimalkan cedera dan mempertahankan prinsip PI; - Melakukan pekerjaan secara tepat dengan teliti dan rapi; - Tetap mempertahankan komunikasi walaupun berhadapan dengan panthom; - Menjaga privasi; - Memperlakukan alat-alat dengan menunjukkan sikap kehati-hatian. C. Dokumentasi - Tulisan rapi dan jelas; - Jika ada koreksi, coretan hanya satu garis, diberi paraf, dan diperbaiki.
6.	KASUS, SKENARIO, TUGAS PESERTA UJIAN, INSTRUKSI KHUSUS PENGUJI, DAN LABORAN	KASUS Ibu hamil TM 3 dengan eklampsi SKENARIO (PS/Manekin/Hybrid) Anda sedang menghadapi seorang pasien dengan diagnosis medis eklampsi dengan TD 210/120 mmHg, hamil 32 minggu di ruang IGD RS. Tong spatel, infus MgSO₄ telah terpasang. Saat ini, pasien akan dilakukan pemasangan dower catheter.

NO	ITEM	PENJELASAN	
	Catatan: Tentukan apakah menggunakan PS, manekin, atau hybrid (Coret yang tidak perlu).	TUGAS PESERTA UJIAN	INSTRUKSI KHUSUS PENGUJI
		1. Lakukan pemasangan kateter. 2. Setelah kateter terpasang, lakukan pemantauan TD dan dengarkan penguji menyebutkan hasil setelah pengukuran ini selesai dilakukan. 3. Catat implementasi dan evaluasi hasil tindakan yang dilakukan pada kertas yang tersedia dan serahkan kepada menguji catatan tersebut.	1. Penguji dapat mendekati peserta ujian apabila penglihatan kurang terjangkau ketika peserta ujian melakukan prosedur tindakan. Dengan catatan, posisi penguji di belakang punggung peserta ujian. 2. Setelah pasien selesai melakukan pengukuran TD, sebutkan hasil pengukuran: - Tekan darah 180/100 mmHg dan Nadi 98x/menit

NO	ITEM	PENJELASAN			
				3. Mengambil catatan implementasi yang diserahkan oleh peserta ujian untuk diberi penilaian.	
		INSTRUKSI TAMBAHAN PENGUJI			
		LABORAN			
		Ada		Bantu laboran.	
		Tidak ada		Rapikan alat dan siapkan BHP untuk peserta selanjutnya.	
7.	DESKRIPSI PS ATAU/DAN MANEKIN, PANDUAN DAN DIALOG PS	DESKRIPSI PS	PANDUAN DIALOG PS DAN PU		
			PESERTA UJIAN	PASIENT SIMULASI	
		DESKRIPSI MANEKIN Manekin: Model panggul perempuan hamil yang pada area genetalia dapat digunakan untuk pemasangan kateter.			
8.		ALAT DAN BHP			

NO	ITEM	PENJELASAN	
	KEBUTUHAN ALAT DAN BHP DAN PENGATURAN ALAT	No	ALAT DAN BHP
		1.	Tensimeter digital
		2.	Bak instrumen yang berisikan: - sepasang sarung tangan - kom kecil yang bertuliskan "betadine" - spuit 50 m dalam keadaan telah dilepas dari kemasannya - kasa secukupnya
		3.	Kom yang bertuliskan air DTT
		4.	Kom yang diisi dengan kapas cebok dan di luar kom ditulis dengan "kapas DTT"
		5.	Tube yang bertuliskan "jelly"
		6.	Kateter Foley dalam kemasan
		7.	Duk bolong dalam kemasan
		8.	Air dalam botol 50/100 mL yang bertuliskan "Aquadest"
		9.	Plester/gunting
		10.	Urine bag tanpa kemasan
		11.	Bengkok
		12.	Tali/verband untuk pengikat urine bag
		13.	Waskom yang bertuliskan 'larutan untuk dekontaminasi alat' (misal larutan klorin 0,5%)
		14.	Tempat sampah medis/nor medis/benda tajam
		15.	Foto kopi kertas yang bertuliskan lembar implementasi
*Sesuai jumlah peserta dalam satu periode putaran + minimal 2 sebagai cadangan			

NO	ITEM	PENJELASAN
		PENGATURAN ALAT 1. Bagian bawah model panggul dialasi dengan underpad dan bagian atas model panggul ini diberikain penutup (selimut). 2. Di bagian samping bawah model panggul tersebut diletakkan: a) Bak instrumen yang berisikan seperangkat alat untuk pemasangan dower kateter telah disiapkan. Seperangkat alat tersebut terdiri dari: - o sepasang sarung tangan - o kom kecil yang bertuliskan "betadine" - o spuit minimal 20 mL (sebaiknya yang 50 mL) dalam keadaan telah dilepas dari kemasannya - o kasa b) Kom yang bertuliskan air DTT c) Kom yang diisi dengan kapas dan pada bagian luar kom ditulis dengan "kapas DTT" d) Tube yang seolah-olah berisi "jelly" e) Kateter Foley dalam kemasan f) Urine bag yang sudah dikeluarkan dari kemasan 3. Di samping model panggul ini diletakkan model lengan yang telah dipasang infus (kondisikan asal netes)
9.	PENULIS	J.M. METHA
10.	REFERENSI	Desristanto, P. (2025). J.M. Metha's Midwifery Series: Asuhan Persalinan.

RUBRIK PENILAIAN UNTUK *ACTUAL MARK*

NO	ITEM		SKOR (3, 2, 1, 0)	
	KOMPETENSI	ITEM	SKOR	KETERANGAN
1.	LANGKAH/ JAWABAN	PEMASANGAN KATETER	3	Jika peserta ujian melakukan semua (11) langkah dengan tepat
			2	Jika peserta ujian melakukan 6-10 dari 11 langkah dengan tepat atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil kurang tepat
			1	Jika peserta ujian melakukan 4-5 dari 11 langkah dengan tepat atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar kurang tepat.
			0	Jika peserta ujian hanya melakukan 1-3 dari 11 atau tidak melakukan apa pun atau semua dilakukan tetapi tidak satu pun yang tepat
2.	KOMPETENSI	PENGUKURAN TD (DIGITAL)	SKOR	
			KETERANGAN	
			3	Jika peserta ujian melakukan semua (7) langkah dengan tepat
			2	Jika peserta melakukan 4-6 dari 7 langkah dengan tepat atau
	LANGKAH/ JAWABAN	1. Mempersiapkan diri 2. Mengecek peralatan 3. Memposisikan pasien 4. Memastikan orifisium uretra siap untuk dimasukkan kateter 5. Memasukkan kateter ke dalam orifisium uretra 6. Memastikan urine keluar 7. Melakukan fiksasi kateter bagian dalam 8. Menyambungkan kateter dengan urine bag 9. Melakukan fiksasi selang kateter bagian luar 10. Memposisikan urine bag 11. Menyelesaikan tindakan		
	LANGKAH/ JAWABAN	1. Mempersiapkan diri 2. Memastikan alat siap pakai 3. Mempersiapkan lengan yang akan diukur (memastikan aliran infus tidak mengalir) 4. Mendekatkan alat		

		5. Memasang manset 6. Mengoperasionalkan alat 7. Menyelesaikan pengukuran		semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil kurang tepat
			1	Jika peserta melakukan 1-3 dari 7 langkah dengan tepat atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar kurang tepat.
			0	Jika peserta ujian tidak melakukan apapun atau semua dilakukan tetapi tidak satu pun yang tepat.
3.	KOMPETENSI	PENDOKUMENTASIAN	SKOR	KETERANGAN
	LANGKAH/JAWABAN	Dokumentasi mempunyai lembar penilaian tersendiri (Lihat lampiran.).	3	Semua (13) item dicatat dengan tepat dan runtun
			2	7-12 dari 13 item dicatat dengan tepat dan runtun
			1	4-6 dari 13 item dicatat dengan tepat dan runtun
			0	< 3 dari 13 item tidak dicatat dengan tepat dan tidak runtun
4.	KOMPETENSI	PERILAKU PROFESIONAL	SKOR	KETERANGAN
	LANGKAH/JAWABAN	Prosedur kerja (pemeriksaan, tindakan) 1. Mengutamakan keselamatan pasien, diri, dan lingkungan, termasuk meminimalkan cedera	3	Semua (7) item dilakukan dengan sesuai.
			2	4-6 dari 7 item datau semua dilakukan tetapi sebagian kecil kurang sesuai

		dan mempertahankan prinsip PI; 2. Melakukan pekerjaan secara tepat dengan teliti dan rapi; 3. Tetap mempertahankan komunikasi walaupun berhadapan dengan panthom; 4. Menjaga privasi; 5. Memperlakukan alat-alat dengan menunjukkan sikap kehati-hatian. Dokumentasi 6. Tulisan rapi dan jelas; 7. Jika ada koreksi, coretan hanya satu garis, diberi paraf, dan diperbaiki.	<table><tr><td>1</td><td>1-3 dari 7 langkah dilakukan atau semua dilakukan tetapi sebagian besar kurang sesuai.</td></tr><tr><td>0</td><td>Tidak ada yang dilakukan.</td></tr></table>	1	1-3 dari 7 langkah dilakukan atau semua dilakukan tetapi sebagian besar kurang sesuai.	0	Tidak ada yang dilakukan.
1	1-3 dari 7 langkah dilakukan atau semua dilakukan tetapi sebagian besar kurang sesuai.						
0	Tidak ada yang dilakukan.						

RUBRIK PENILAIAN UNTUK *GLOBAL PERFORMANCE*

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

LAMPIRAN PENDOKUMENTASIAN

Waktu (tgl/pkl.)	Kegiatan yang dilakukan	Evaluasi hasil tindakan
	Memasang kateter	
Isi dengan waktu ketika anda berada di stasiun ini	1. Memberitahu tindakan yang akan dilakukan kepada pasien/keluarga pasien (walaupun dengan phantom)	Kateter berhasil dipasang, urine tertampung di urine bag.
	2. Melakukan pengetesan kelayakan kateter (tes pengembangan balon sebelum digunakan)	
	3. Melakukan tindakan aseptis dan antisepsis (pra pemasangan: penggunaan sarung tangan, vulva hygiene, penggunaan duk bolong steril, dan pemberian betadine). Selama pemasangan, tidak menyentuh langsung selang kateter	
	4. Meminimalkan rasa sakit ketika kateter dimasukkan (pemberian jelly pada orifisium uretra)	
	5. Memasukkan ujung selang kateter secara bertahap (pertama 5 cm → urine keluar → masukkan lagi sampai 10 cm)	

Waktu (tgl/pkl.)	Kegiatan yang dilakukan	Evaluasi hasil tindakan
	6. Memasukkan aquadest 30 mL ke dalam balon	
	7. Meyakinkan selang kateter bagian dalam terfiksasi	
	8. Menyambung selang kateter ke urine bag	
	9. Menfiksasi selang kateter bagian luar ke sebelah paha bagian dalam dengan menggunakan plester	
	10. Menggantungkan urine bag di sisi tempat tidur dengan posisi lebih rendah dari tubuh	
	11. Memposisikan kembali pasien dengan nyaman	
	12. Menyelesaikan tindakan (membuang BHP, mendekontaminasi alat yang telah digunakan, mencuci tangan)	
	Mengukur tekanan darah dengan tensimeter digital	
	13. Mengukur tekanan darah dengan tensimeter digital pada lengan sebelah ...	Hasil pengukuran 180/100 mmHg, N 98x/menit

BAB 12

Penutup: Pentingnya Penguasaan Keterampilan Klinis Oleh Bidan

Dalam profesi kebidanan, penguasaan keterampilan klinis adalah salah satu aspek terpenting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi. Bidan berperan sebagai tenaga kesehatan utama dalam mendampingi proses kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Mereka bertanggung jawab tidak hanya terhadap kelancaran proses tersebut, tetapi juga terhadap deteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, keterampilan klinis yang mumpuni menjadi landasan penting bagi bidan untuk memberikan layanan kesehatan yang aman dan efektif.

Penguasaan keterampilan klinis oleh bidan berkaitan langsung dengan keselamatan ibu dan bayi. Bidan yang terampil dapat mengidentifikasi tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan persalinan, seperti preeklamsia, perdarahan pascapersalinan, atau tanda-tanda gawat janin. Dengan keterampilan klinis yang baik, bidan dapat segera melakukan tindakan yang tepat atau merujuk pasien ke fasilitas yang lebih lengkap sebelum komplikasi tersebut membahayakan nyawa.

Selain itu, keterampilan klinis dalam menangani persalinan normal juga memastikan bahwa proses kelahiran berjalan lancar tanpa intervensi medis yang berlebihan. Bidan yang terampil dapat memberikan dukungan yang tepat selama proses persalinan, membantu ibu mengatasi rasa sakit, serta memastikan posisi dan kondisi janin selama persalinan dalam keadaan optimal.

Deteksi dini terhadap komplikasi merupakan salah satu alasan utama mengapa penguasaan keterampilan klinis sangat penting. Bidan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan klinis yang baik mampu mengenali perubahan kecil dalam kondisi ibu atau bayi yang bisa menjadi indikasi komplikasi serius. Misalnya, perubahan pada tekanan darah ibu, denyut jantung janin, atau kondisi rahim pascapersalinan dapat menjadi petunjuk penting bagi bidan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dengan penguasaan keterampilan klinis, bidan juga dapat melakukan intervensi awal yang tepat, seperti stabilisasi pasien sebelum dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi, sehingga risiko komplikasi lebih lanjut bisa diminimalkan.

Dalam praktik kebidanan, situasi darurat dapat terjadi kapan saja, seperti persalinan macet, eklampsia, atau bayi yang mengalami gawat janin. Penguasaan keterampilan klinis memungkinkan bidan untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi ini. Keterampilan dalam memantau kondisi ibu dan bayi secara real-time, serta kemampuan untuk menilai data klinis, sangat penting dalam membantu bidan menentukan langkah terbaik yang harus diambil dalam situasi darurat. Pengambilan keputusan yang baik dalam kondisi darurat dapat menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, mengurangi morbiditas, dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

Penguasaan keterampilan klinis juga berperan penting dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Dengan keterampilan yang memadai, bidan dapat memberikan perawatan yang komprehensif, mulai dari memberikan edukasi tentang kehamilan dan persalinan, melakukan pemeriksaan antenatal yang tepat, hingga memberikan konseling terkait menyusui dan perawatan bayi. Bidan yang terampil dapat memastikan bahwa setiap ibu dan bayi mendapatkan asuhan terbaik berdasarkan standar klinis kebidanan yang diakui.

Keterampilan klinis yang baik juga membuat bidan mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter

kandungan atau perawat, untuk memastikan bahwa asuhan yang diberikan terkoordinasi dengan baik, terutama dalam situasi yang membutuhkan rujukan atau intervensi medis tambahan.

Penguasaan keterampilan klinis tidak hanya penting bagi keselamatan pasien, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri bidan dalam menjalankan tugas mereka. Bidan yang terampil akan merasa lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi klinis, mulai dari kondisi normal hingga komplikasi yang mungkin muncul. Kepercayaan diri ini membantu bidan menjalankan perannya dengan lebih efektif dan efisien.

Profesionalisme bidan juga akan meningkat seiring dengan penguasaan keterampilan klinis. Bidan yang kompeten akan lebih dihargai oleh pasien, rekan kerja, serta tenaga kesehatan lainnya, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Dunia kesehatan terus berkembang dengan berbagai inovasi dan penemuan baru, termasuk dalam bidang kebidanan. Bidan yang memiliki keterampilan klinis yang solid akan lebih siap dalam menghadapi perubahan ini. Misalnya, adopsi teknologi baru dalam pemantauan janin atau metode terbaru dalam manajemen persalinan dapat diimplementasikan lebih baik oleh bidan yang memiliki dasar keterampilan klinis yang kuat. Kesiapan ini penting, karena dengan demikian bidan tidak hanya berfokus pada keterampilan tradisional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.

Penguasaan keterampilan klinis oleh bidan merupakan faktor kunci dalam memastikan keselamatan dan kualitas perawatan bagi ibu dan bayi. Keterampilan yang baik tidak hanya membantu bidan dalam menjalankan tugas sehari-hari, tetapi juga dalam menghadapi situasi darurat, mendeteksi komplikasi secara dini, dan memberikan pelayanan kesehatan yang holistik. Dengan

penguasaan keterampilan klinis yang memadai, bidan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memastikan keselamatan pasien, serta berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat sejak awal kehidupan.

Dalam dunia kebidanan yang terus berkembang, penguasaan keterampilan klinis juga memastikan bahwa bidan dapat terus berkembang seiring dengan perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan mereka tenaga kesehatan yang profesional dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ini semua juga merupakan hal-hal yang ingin dicapai oleh OSCE sebagai salah satu bentuk uji kompetensi bidan.

Ujian Klinis yang Objektif dan Terstruktur (OSCE) merupakan salah satu metode penilaian kompetensi yang digunakan secara luas dalam pendidikan kesehatan, termasuk kebidanan. OSCE dirancang untuk menguji keterampilan klinis siswa secara objektif dan sistematis melalui serangkaian stasiun. Pada setiap stasiun, siswa harus menyelesaikan tugas-tugas klinis tertentu seperti pemeriksaan fisik, pengambilan keputusan klinis, dan komunikasi dengan pasien dalam waktu yang ditentukan.

Sebagai uji kompetensi, OSCE dinilai efektif karena tidak hanya menguji pengetahuan teoretis tetapi juga kemampuan praktis, pengambilan keputusan cepat, dan keterampilan interpersonal. Hal ini memastikan bahwa calon bidan tidak hanya memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan tersebut dalam situasi klinis nyata. OSCE juga memberikan penilaian yang lebih objektif karena menggunakan rubrik penilaian standar, sehingga setiap peserta dinilai dengan kriteria yang sama.

Dengan OSCE, siswa dapat dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, yang memastikan bahwa mereka kompeten dan siap memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas kepada ibu dan bayi.

Daftar Pustaka

1. Aktaş, Y. Y., & Karabulut, N. (2016). A Survey on Turkish nursing students' perception of clinical learning environment and its association with academic motivation and clinical decision making. *Nurse Education Today*, 36, 124-128.
2. Bahaziq, W., & Crosby, E. (2011). Physician professional behaviour affects outcomes: a framework for teaching professionalism during anesthesia residency. *Canadian journal of anaesthesia. Journal canadien d'anesthésie*, 58(11), 1039–1050. <https://doi.org/10.1007/s12630-011-9579-2>
3. Evans, S. C., Roberts, M. C., Keeley, J. W., Blossom, J. B., Amaro, C. M., Garcia, A. M., ... Reed, G. M. (2015). *Vignette methodologies for studying clinicians' decision-making: Validity, utility, and application in ICD-11 field studies. International Journal of Clinical and Health Psychology*, 15(2), 160–170. doi:10.1016/j.ijchp.2014.12.001
4. González-Fernández, R., Ruiz-Cabezas, A., Domínguez, M. C. M., Subía-Álava, A. B., & Salazar, J. L. D. (2024). Teachers' teaching and professional competences assessment. *Evaluation and program planning*, 103, 102396. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2023.102396>
5. Hanushek, E. A. (2011). The economic value of higher teacher quality. *Economics of Education Review*, 30(3), 466–479.
6. Harden, R.M and Laidlaw, J.M. (2017) *Essential Skills for A Medical Teacher: An Introduction to Teaching and Learning in Medicine*. Second edition. Elsevier.
7. Meroni, E. C., Vera-Toscano, E., & Costa, P. (2015). *Can low skill teachers make good students? Empirical evidence from PIAAC and PISA. Journal of Policy Modeling*, 37(2), 308–323. doi:10.1016/j.jpolmod.2015.02.006
8. Mestdagh, E., Timmermans, O., Fontein-Kuipers, Y., & Van Rompaey, B. (2019). Proactive behaviour in midwifery practice:

A qualitative overview based on midwives' perspectives. *Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives*, 20, 87–92.
<https://doi.org/10.1016/j.srhc.2019.04.002>

9. Mitchell, M. L., Jeffrey, C. A., Henderson, A., Glover, P., Nulty, D. D., Kelly, M. A., ... Knight, S. (2014). *Using an Objective Structured Clinical Examination for Bachelor of Midwifery students' preparation for practice. Women and Birth*, 27(2), 108–113. doi:10.1016/j.wombi.2013.12.002
10. National Academies. (2007). Study of teacher preparation programs in the United States. Retrieved December 1, 2006, from <http://www.nationalacademies.org/teacherprep/>
11. OECD Director for Education and Skills, speaking on the occasion of the launch of the Teaching and Learning International Survey (TALIS)
12. Papadakis, M. A., Hodgson, C. S., Teherani, A., & Kohatsu, N. D. (2004). Unprofessional behavior in medical school is associated with subsequent disciplinary action by a state medical board. *Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges*, 79(3), 244–249.
<https://doi.org/10.1097/00001888-200403000-00011>
13. Patey, A. M., Fontaine, G., Francis, J. J., McCleary, N., Presseau, J., & Grimshaw, J. M. (2023). Healthcare professional behaviour: health impact, prevalence of evidence-based behaviours, correlates and interventions. *Psychology & health*, 38(6), 766–794. <https://doi.org/10.1080/08870446.2022.2100887>
14. Schlesinger M. (2002). A loss of faith: The sources of reduced political legitimacy for the American medical profession. *The Milbank Quarterly*. 80(2):185-235
15. Sweet L, Glover P. (2011). Utilizing follow throughs in midwifery. In: Billett S, Henderson A, editors. *Developing learning professional integrating experiences in university and practice settings*. USA: Springer.

Biodata

Penulis dan Editor

Panca Desristanto

Penulis

Panca lulus dari S1 dan S2 UGM, dengan mengambil jurusan Sastra Inggris. Namun, sejak tahun 2006, mengajar dan berkecimpung dalam pendidikan kesehatan, pertamanya di Program Konsultan Obgyn RSUP Sardjito dan Magister Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) UGM, menjadi perhatian utamanya. Setelah itu, kepindahannya ke Program NPT Project di FK UGM sebagai penerjemah mengajarnya banyak hal tentang ilmu kedokteran dan kesehatan dan bagaimana menyusun soal yang berkualitas dari para dokter dosen yang bergelar profesor dan doktor untuk lulusan yang berkualitas. Dengan bekal pengetahuan yang didapatnya saat mengajar di Program KIA UGM, ilmu-ilmu obstetrik, genekologi, dan kebidanan menjadi sangat mudah untuk dituangkan ke dalam tulisannya, dengan dibantu oleh mentor yang sangat handal, yaitu dosen dan praktisi kebidanan sangat senior J.M. Metha.

Berbekal paket lengkap keilmuan, yaitu pengetahuan dan praktik klinis kebidanan, J.M. Metha mengutamakan benarnya asuhan kebidanan, baik secara teori dan praktik di lapangan. Pengalamannya sebagai praktisi di berbagai latar layanan kesehatan, baik dengan praktisi luar negeri maupun dalam negeri, dengan latar perkotaan dan pedesaan, membuatnya dapat mengaplikasikan praktik klinis kebidanan dengan presisi yang akurat. Hal ini ditambah dengan latar belakang pendidikan S2, yaitu Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan (IPK) UGM dan pelatihan untuk menjadi seorang trainer pelatihan klinis (advanced trainer) di Australia, yang menjadikannya praktisi pendidikan kebidanan yang handal dalam pembuatan alat bantu ajar keterampilan klinis kebidanan (dengan predikat Haki dan Paten) dan praktisi lapangan yang sangat menguasai pasien dengan berbagai kondisi.

Maryam Sorohiti

Editor Bahasa

Maryam Sorohiti merupakan seorang dosen aktif di Prodi Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yaitu Sastra Inggris UGM Indonesia dan Jurusan Teaching English as a Second Language (TESL) di International Islamic University Malaysia. Maryam mulai mengajar di UMY sejak tahun 1998 dan sebagian besar mengajar tata bahasa atau structure. Dari pengajarannya ini, keahlian dalam mengenali keakuratan dari keterbacaan naskah dari segi tata bahasa atau sintaksis dan dari segi tata makna atau semantik menjadi bidang kepakaran yang luar biasa. Itulah sebabnya, fokusnya untuk membantu editing naskah-naskah baik berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia menjadikannya praktisi editing yang handal.

SINOPSIS

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan OSCE adalah memastikan keandalan penyusunan soal dan penilaian oleh penguji. Penyusun soal harus terpapar dengan dan menguasai keterampilan klinis, dalam hal ini kebidanan, yang benar dan mumpuni. Tanpa kemampuan ini, penyusun soal tidak dapat berbuat banyak untuk menghasilkan soal yang benar dan berkualitas. Pengembangan soal OSCE dalam bidang kebidanan sangat penting karena beberapa alasan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, keselamatan pasien, dan kesiapan profesional di lapangan. Oleh karena itu, soal yang digunakan harus berdasarkan data lapangan yang akurat.

Soal OSCE yang dikembangkan dengan baik memberikan umpan balik yang spesifik dan berguna bagi siswa. Dengan mendapatkan penilaian atas kinerja mereka, siswa dapat mengetahui area mana yang perlu mereka tingkatkan, baik dari segi keterampilan klinis maupun komunikasi dengan pasien. Dengan demikian, pengembangan soal OSCE kebidanan penting untuk memastikan bahwa siswa kebidanan mendapatkan pelatihan yang tepat, dinilai secara akurat, dan siap menghadapi tuntutan klinis di dunia nyata.

Cetak biru dan template soal sangat penting untuk disusun dengan baik. Kedua hal ini akan memudahkan para penyusun soal dalam membuat soal sesuai dengan kisi-kisi soal yang sudah ditetapkan untuk setiap stasiun. Menjaga kualitas soal di setiap stasiun OSCE sangat penting untuk menjaga reliabilitas dan validitas ujian. Lokakarya tinjauan sejawat dapat menjadi langkah efektif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah dalam desain stasiun baru. Setelah proses peninjauan selesai, uji coba stasiun dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan sebelum stasiun tersebut digunakan dalam ujian yang sebenarnya. Akhirnya, setelah stasiun baru mulai digunakan, pemantauan kualitas pertanyaan OSCE secara berkelanjutan sangat disarankan. Untuk itu, buku ini sangat bermanfaat untuk dimiliki dan dipelajari oleh setiap dosen kebidanan di Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan OSCE adalah memastikan keandalan penyusunan soal dan penilaian oleh penguji. Penyusun soal harus terpapar dengan dan menguasai keterampilan klinis, dalam hal ini kebidanan, yang benar dan mumpuni. Tanpa kemampuan ini, penyusun soal tidak dapat berbuat banyak untuk menghasilkan soal yang benar dan berkualitas. Pengembangan soal OSCE dalam bidang kebidanan sangat penting karena beberapa alasan yang berkaitan dengan kualitas pendidikan, keselamatan pasien, dan kesiapan profesional di lapangan. Oleh karena itu, soal yang digunakan harus berdasarkan data lapangan yang akurat.

Soal OSCE yang dikembangkan dengan baik memberikan umpan balik yang spesifik dan berguna bagi siswa. Dengan mendapatkan penilaian atas kinerja mereka, siswa dapat mengetahui area mana yang perlu mereka tingkatkan, baik dari segi keterampilan klinis maupun komunikasi dengan pasien. Dengan demikian, pengembangan soal OSCE kebidanan penting untuk memastikan bahwa siswa kebidanan mendapatkan pelatihan yang tepat, dinilai secara akurat, dan siap menghadapi tuntutan klinis di dunia nyata.

Cetak biru dan template soal sangat penting untuk disusun dengan baik. Kedua hal ini akan memudahkan para penyusun soal dalam membuat soal sesuai dengan kisi-kisi soal yang sudah ditetapkan untuk setiap stasiun. Menjaga kualitas soal di setiap stasiun OSCE sangat penting untuk menjaga reliabilitas dan validitas ujian. Lokakarya tinjauan sejawat dapat menjadi langkah efektif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah dalam desain stasiun baru. Setelah proses peninjauan selesai, uji coba stasiun dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan sebelum stasiun tersebut digunakan dalam ujian yang sebenarnya. Akhirnya, setelah stasiun baru mulai digunakan, pemantauan kualitas pertanyaan OSCE secara berkelanjutan sangat disarankan. Untuk itu, buku ini sangat bermanfaat untuk dimiliki dan dipelajari oleh setiap dosen kebidanan di Indonesia.

ISBN 978-623-8775-61-3



Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

